AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 10 · NR · ATLAS

## ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

# NEUROLOGÍA

**Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después**

| 70 | 23 | 3 |
|---|---|---|
| IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES | TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO | PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS» |

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 10

# Índice por tema

**Cómo usarlo.** Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 10 donde se trata esa imagen o su tema.


**Parecidas pero distintas** 39

**Índice por tipo de imagen** 42

**Soluciones de la autoevaluación** 45

**Signos con nombre propio** 41

**Autoevaluación** 43

## 01 Enfermedad Cerebrovascular y Urgencias Neurovasculares

### 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico

01 ACV isquémico: signos precoces en la TC 4

02 Infartos establecidos por territorio 4

03 AngioTC: oclusión de la ACM 5

### 10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT)

04 RM de difusión: infarto 5

05 Émbolo de Hollenhorst 6

06 Estenosis carotídea en la angiografía 6

07 RM con difusión y perfusión 7

08 Angiografía carotídea normal 7

09 Fibrilación auricular 8

### 10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea

10 Hematoma profundo (putaminal) 8

11 Hematoma talámico 9

12 Hematoma lobar 9

13 Hematoma cerebeloso 10

### 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática

14 Localización de los aneurismas 10

15 Parálisis del III par 11

16 Síndrome de Terson 11

17 Hidrocefalia 12

### 10.5 Trombosis Venosa Cerebral

18 Papiledema 12

19 Trombosis del seno sagital 13

20 Defecto de relleno venoso 13

## 02 Cefaleas, Síndromes Convulsivos y Epilepsia

### 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

21 Aura visual: espectro de fortificación 14

### 10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino

22 Síndrome de Horner en la cefalea en racimos 14

23 Ramas del trigémino 15

### 10.8 Epilepsia del Adulto

24 Crisis de ausencia en el EEG 15

25 Stevens-Johnson por anticonvulsivantes 16

26 Hiperplasia gingival por fenitoína 16

### 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope

27 Mordedura lateral de la lengua 17

## 03 Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas

### 10.11 Enfermedad de Parkinson

28 Micrografía 17

29 Postura parkinsoniana 18

### 10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

30 Signo de la cruz caliente 18

31 Leucoaraiosis e infartos lacunares 19

32 Leucoaraiosis en RM FLAIR 19

### 10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

33 Espiral con temblor 20

34 Espiral de Arquímedes 20

35 Crisis oculógira 21

# Índice por tema · continuación


**10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve**

36 Atrofia hipocampal ..... 21
37 PET-FDG en Alzheimer ..... 22
38 Test del reloj ..... 22
39 Hidrocefalia normotensiva ..... 23
40 Hidrocefalia normotensiva en TC y RM ..... 23

**10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal**

41 Demencia frontotemporal ..... 24

## 04 Patología Neuromuscular, Desmielinizante y Nervio Periférico

**10.17 Miastenia Gravis**

42 Ptosis miasténica: antes y después ..... 24
43 Ptosis miasténica ..... 25
44 Test del hielo ..... 25

**10.18 Esclerosis Múltiple**

45 Defecto pupilar aferente relativo ..... 26
46 Neuritis óptica en la RM ..... 26
47 Oftalmoplejía internuclear ..... 27
48 Neuromielitis óptica ..... 27

**10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento**

49 Parálisis facial periférica ..... 28
50 Parálisis facial central vs periférica ..... 28
51 Síndrome de Ramsay Hunt ..... 29
52 Maniobra de Phalen ..... 29
53 Signo de Froment ..... 30
54 Atrofia de los intrínsecos de la mano ..... 30
55 Mano caída ..... 31

**10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central**

56 Registro del impulso cefálico ..... 31
57 Maniobra de Dix-Hallpike ..... 32
58 Maniobra de Epley ..... 32
59 Atrofia cerebelosa ..... 33

## 05 Geriatría Clínica y Grandes Síndromes Geriátricos

**10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)**

60 Sitios frecuentes de úlceras por presión ..... 33
61 Escara sacra necrótica ..... 34

**10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES**

62 Fractura de cadera ..... 34
63 Fractura subcapital del fémur ..... 35
64 Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV) ..... 35

**10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor**

65 Cascada de prescripción ..... 36

**10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor**

66 Retinopatía hipertensiva ..... 36
67 IAM anterior con SDST ..... 37
68 IAM inferior con SDST ..... 37

**10.26 Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida**

69 Metástasis óseas múltiples ..... 38
70 Compresión medular epidural ..... 38

## 01 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

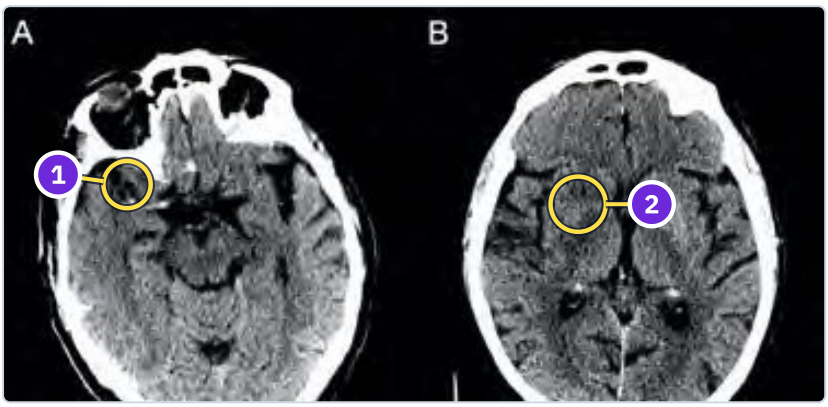



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 62

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. ACM hiperdensa
2. Pérdida del ribete insular

**DIAGNÓSTICO**

### ACV isquémico: signos precoces en la TC

*A: arteria cerebral media hiperdensa. B: borramiento de la ínsula y los ganglios basales.*

**CONDUCTA INICIAL**

TC sin contraste para descartar sangre: trombolisis dentro de 4,5 h.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.4.001` **TAC de encefalo y columna**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Hemorragia: hiperdensa en el parénquima.

**PREGUNTA REAL**

**Julio 2019 · P93** «Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para…»
→ **Realizar trombólisis**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 6**
Tema 10.1

**Clase 10.1** en video

## 02 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

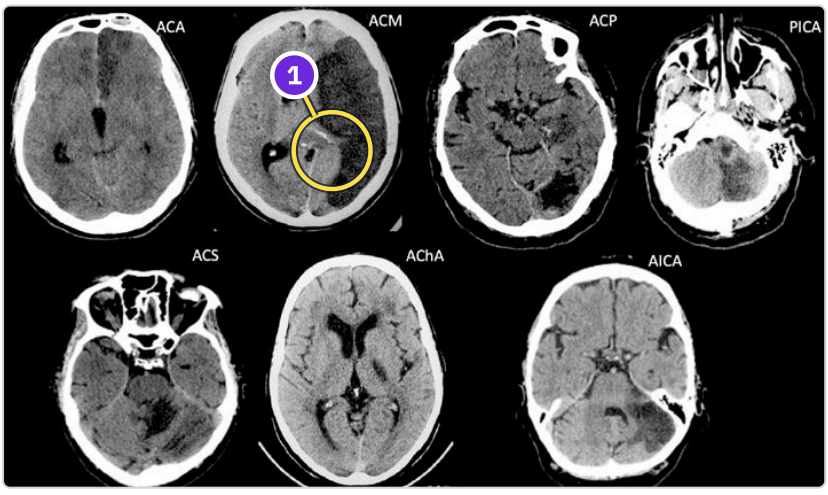



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 63

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Infarto de la ACM

**DIAGNÓSTICO**

### Infartos establecidos por territorio

*Zonas hipodensas según la arteria ocluida.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fuera de ventana: prevención secundaria y rehabilitación.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Tumor: no respeta territorios vasculares.

**PREGUNTA REAL**

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 7**
Tema 10.1

**Clase 10.1** en video

## 03 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 62

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Oclusión de la ACM

**DIAGNÓSTICO**

### AngioTC: oclusión de la ACM

*Corte del contraste en la arteria cerebral media (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Oclusión de gran vaso: trombectomía mecánica.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Vaso permeable: sin corte.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 7** Tema 10.1

**Clase 10.1** en video

## 04 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

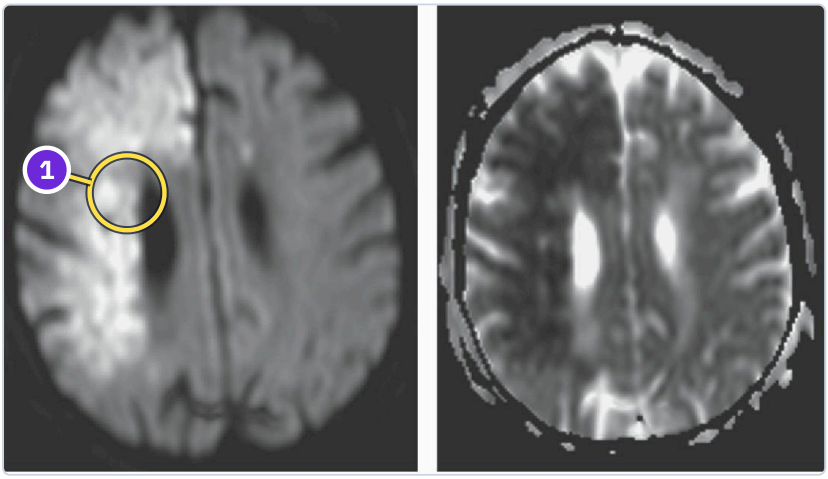



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 94

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Lesión en difusión

**DIAGNÓSTICO**

### RM de difusión: infarto

*Hiperseñal en difusión aunque los síntomas se hayan ido.*

**CONDUCTA INICIAL**

Difusión positiva = infarto, no AIT.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

AIT: difusión negativa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 14** Tema 10.2

**Clase 10.2** en video

## 05 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

FONDO DE OJO

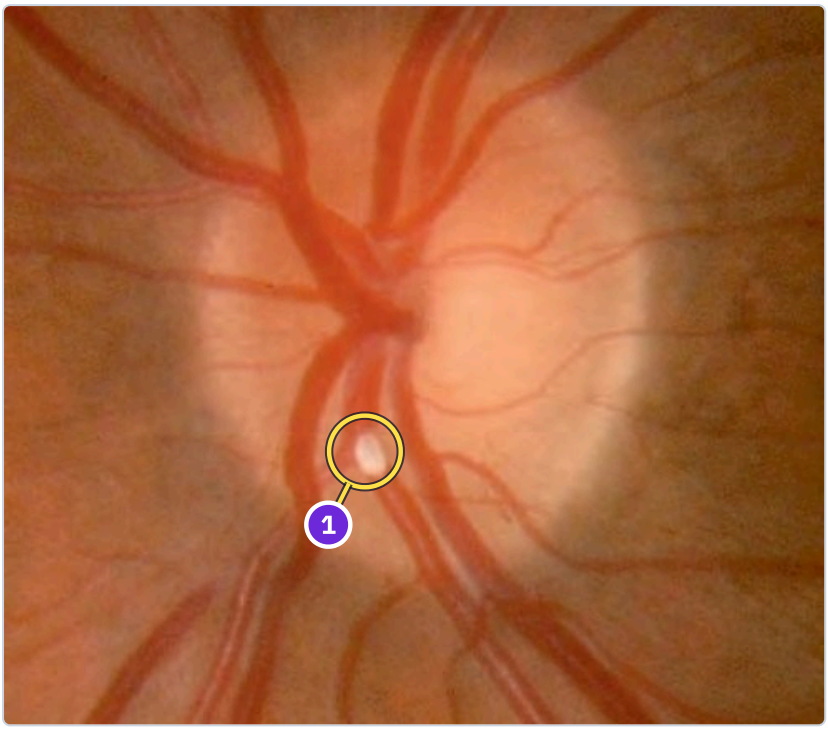



Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 562

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Émbolo de colesterol

**DIAGNÓSTICO**

### Émbolo de Hollenhorst

*Placa brillante de colesterol en una arteriola retiniana.*

**CONDUCTA INICIAL**

Amaurosis fugax: estudiar la carótida ipsilateral.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.2.007 | Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 4.01.1.046 | Insuficiencia cerebro vascular | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Exudado: no está dentro del vaso.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 14** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

## 06 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

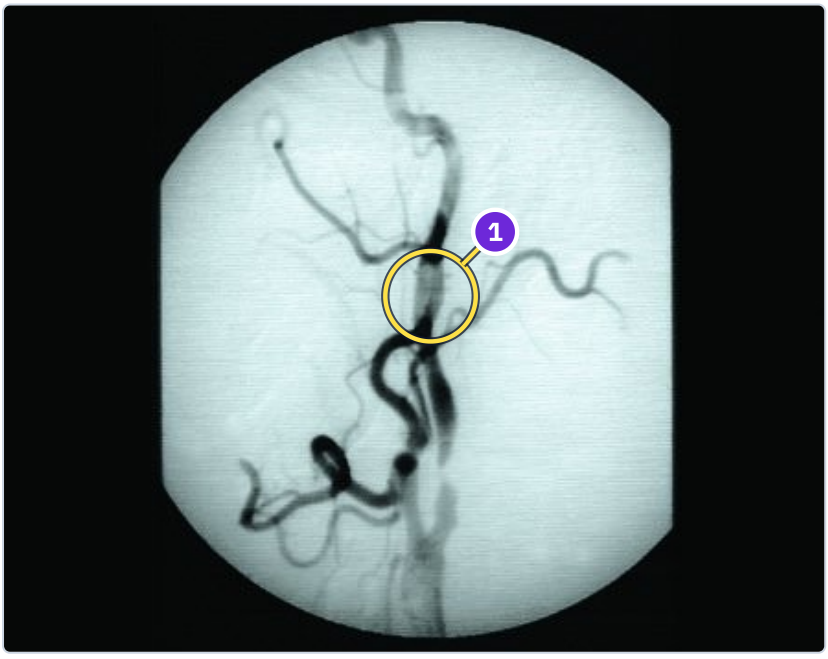



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 36

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Estenosis

**DIAGNÓSTICO**

### Estenosis carotídea en la angiografía

*Estrechez del bulbo carotídeo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Estenosis sintomática ≥ 70%: endarterectomía en menos de 2 semanas.

| | | |
|---|---|---|
| 4.01.1.046 | Insuficiencia cerebro vascular | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.10.3.002 | Prevención de factores de riesgo cerebrovascular | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Disección: estenosis larga y afilada.

PREGUNTA REAL

**Julio 2024 · P151** «Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el…» → **Ecodoppler de carótidas**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

## 07 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

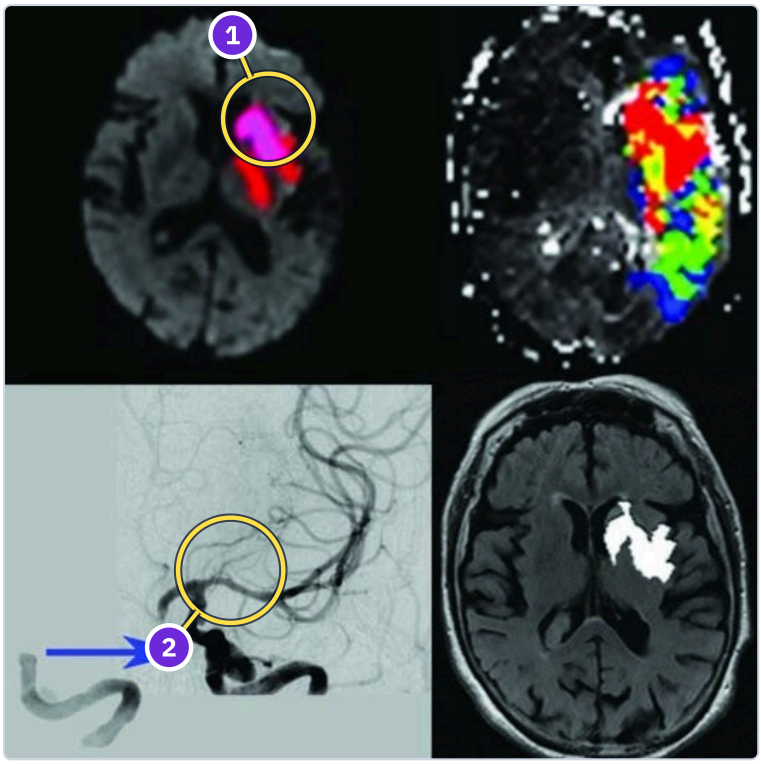



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st ed., p. 3376

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Infarto
2. Oclusión

**DIAGNÓSTICO**

### RM con difusión y perfusión

*Infarto en difusión y área mayor de hipoperfusión, con oclusión en la angiografía (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Desacople difusión-perfusión: tejido salvable.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Infarto antiguo: hipodenso sin difusión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

**Clase 10.2** en video

## 08 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

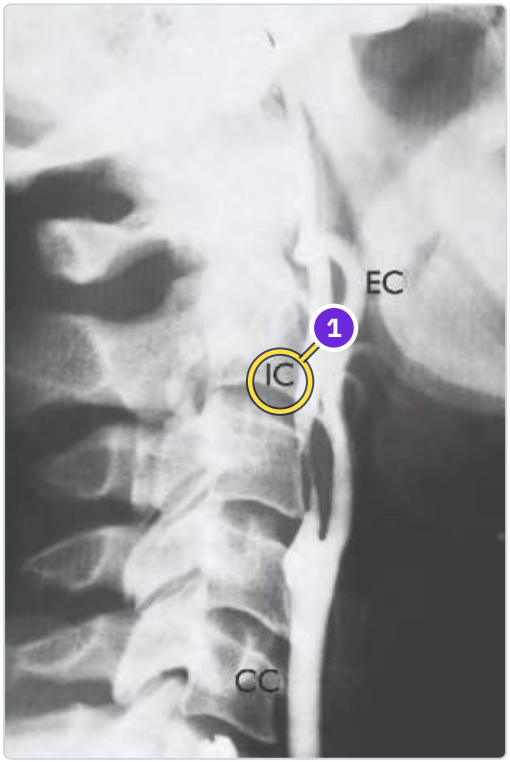



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 973

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Carótida interna

**DIAGNÓSTICO**

### Angiografía carotídea normal

*Carótida común (CC), interna (IC) y externa (EC).*

**CONDUCTA INICIAL**

Primero eco-Doppler o angioTAC.

`4.01.1.046` **Insuficiencia cerebro vascular**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

La externa da ramas en el cuello; la interna no.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

**Clase 10.2** en video

## 09 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

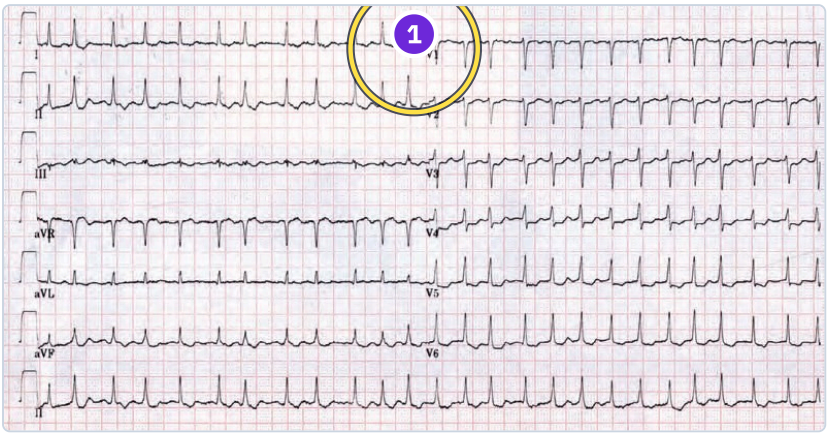



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 253

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 R-R irregular

**DIAGNÓSTICO**

### Fibrilación auricular

*Sin ondas P y R-R irregular.*

**CONDUCTA INICIAL**

ACV cardioembólico: anticoagular.

`1.01.2.003` **Embolia cardiogénica**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Flutter: ondas F en serrucho.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

**Clase 10.2** en video

## 10 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

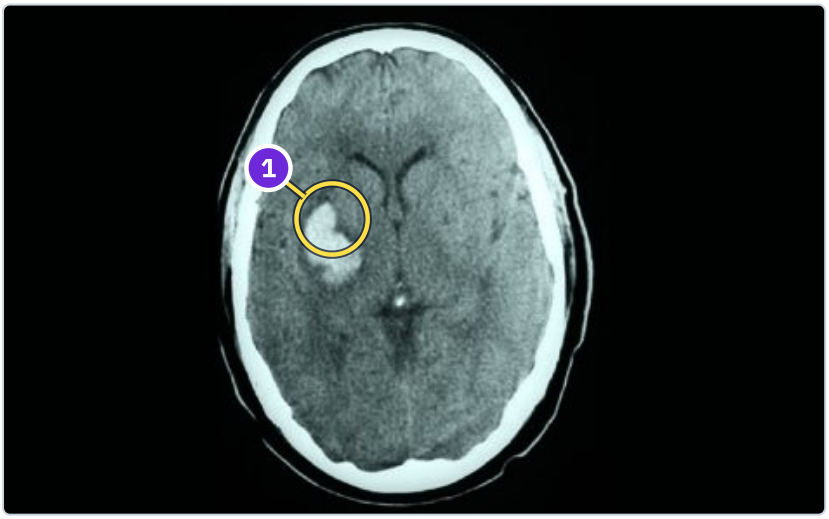



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 42

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hematoma

**DIAGNÓSTICO**

### Hematoma profundo (putaminal)

*Hiperdensidad en los ganglios basales.*

**CONDUCTA INICIAL**

Bajar la presión sistólica a 140 y revertir anticoagulantes.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Infarto: hipodenso.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

**Clase 10.3** en video

## 11 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

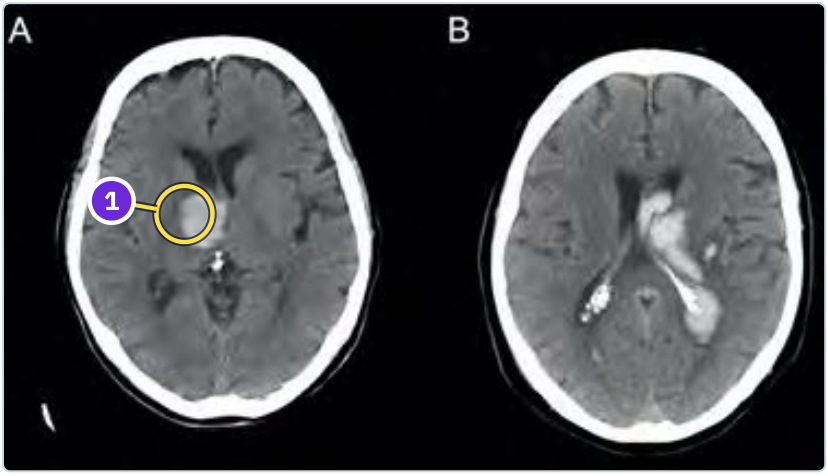



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 67

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hematoma talámico

**DIAGNÓSTICO**

### Hematoma talámico

*Sangrado del tálamo con paso a los ventrículos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hemihipoestesia mayor que el déficit motor.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.2.007 | Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.10.2.009 | Hipertensión endocraneana | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Putaminal: predomina lo motor.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

**Clase 10.3** en video

## 12 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

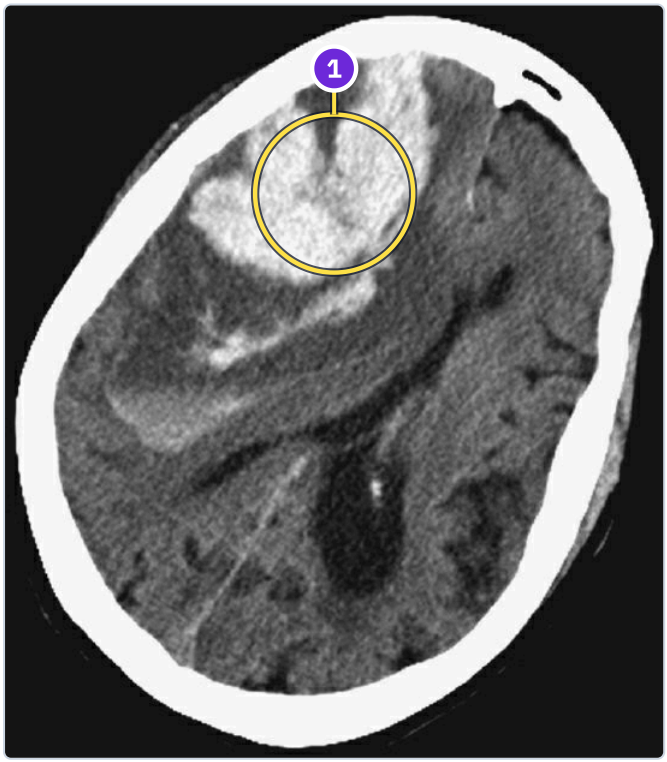



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 90

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hematoma lobar

**DIAGNÓSTICO**

### Hematoma lobar

*Hematoma cortical grande.*

**CONDUCTA INICIAL**

Adulto mayor: angiopatía amiloide.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.2.007 | Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Tumor sangrante: realza con contraste.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

**Clase 10.3** en video

## 13 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

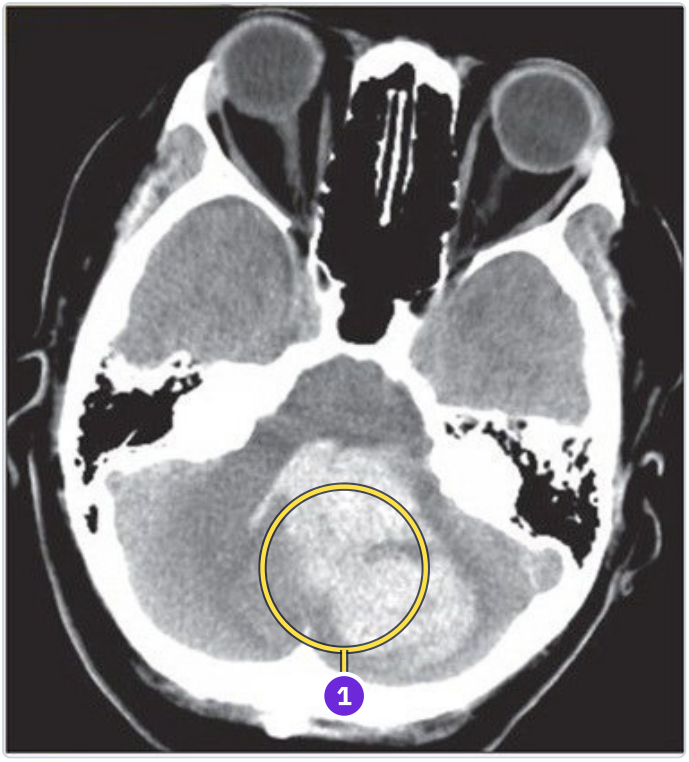



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, Fig. 1 / p. 142

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hematoma cerebeloso

**DIAGNÓSTICO**

### Hematoma cerebeloso

*Hiperdensidad cerebelosa que comprime el IV ventrículo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Mayor de 3 cm o con compresión: cirugía urgente.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Vértigo periférico: TC normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA p. 20 Tema 10.3

Clase 10.3 en video

## 14 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

ESQUEMA

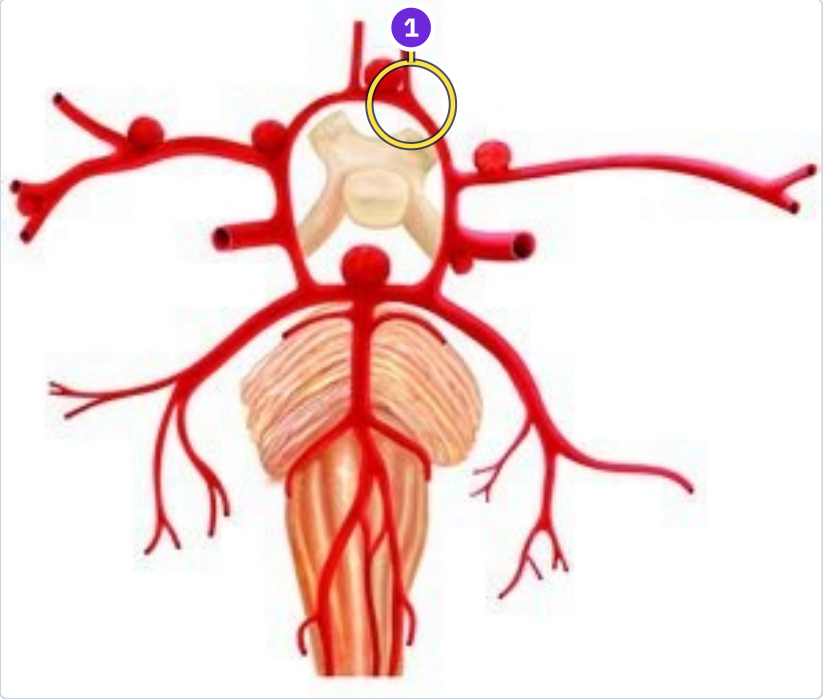



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 43

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Comunicante anterior

**DIAGNÓSTICO**

### Localización de los aneurismas

*Polígono de Willis: la comunicante anterior es la más frecuente.*

**CONDUCTA INICIAL**

HSA: angioTAC o angiografía; tratamiento del aneurisma.

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.4.003 **Angiografía**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Aneurisma de la comunicante posterior: compromete el III par.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P178** «Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha…» → **Angiografía cerebral**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA p. 24 Tema 10.4

Clase 10.4 en video

## 15 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

FOTO CLÍNICA

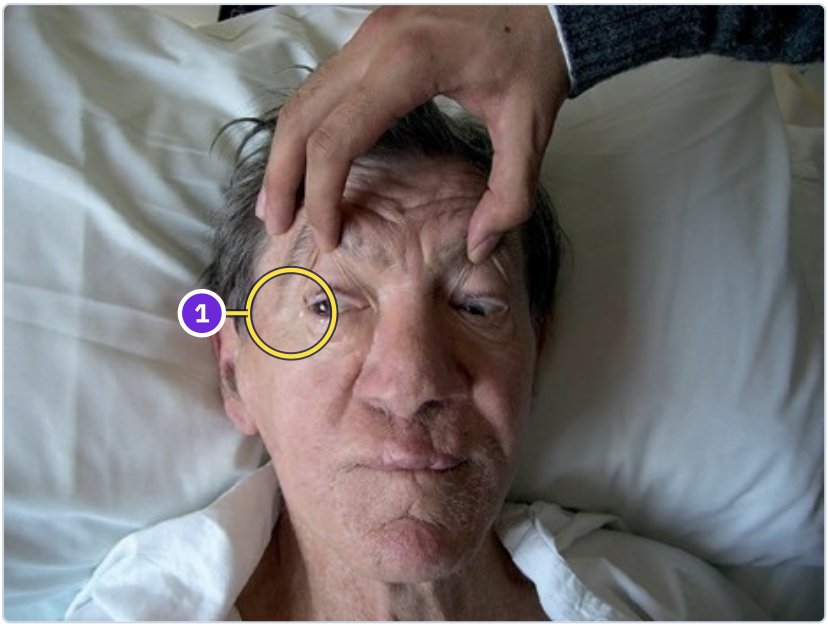



Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 546

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ojo desviado afuera

**DIAGNÓSTICO**

### Parálisis del III par

*Ptosis, midriasis y ojo abajo y afuera.*

**CONDUCTA INICIAL**

Con midriasis: aneurisma de la comunicante posterior hasta demostrar lo contrario.

6.02.2.009 **Parálisis III par + midriasis**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

III par diabético: respeta la pupila.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 23** Tema 10.4

**Clase 10.4** en video

## 16 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

FONDO DE OJO

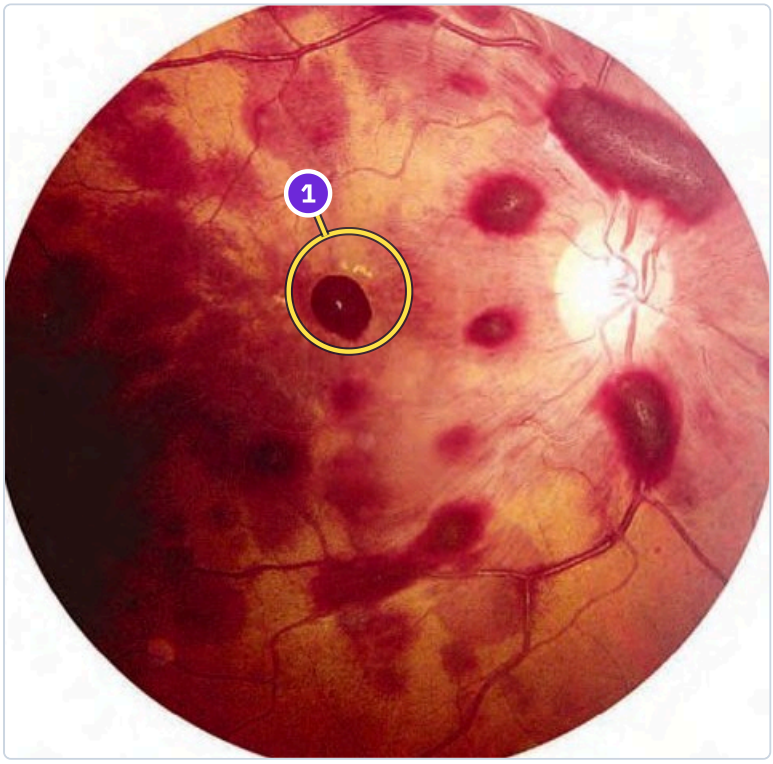



Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 736

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hemorragia subhialoidea

**DIAGNÓSTICO**

### Síndrome de Terson

*Hemorragias subhialoideas en una HSA grave.*

**CONDUCTA INICIAL**

Marcador de HSA grave.

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Retinopatía hipertensiva: hemorragias en llama.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 23** Tema 10.4

**Clase 10.4** en video

## 17 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

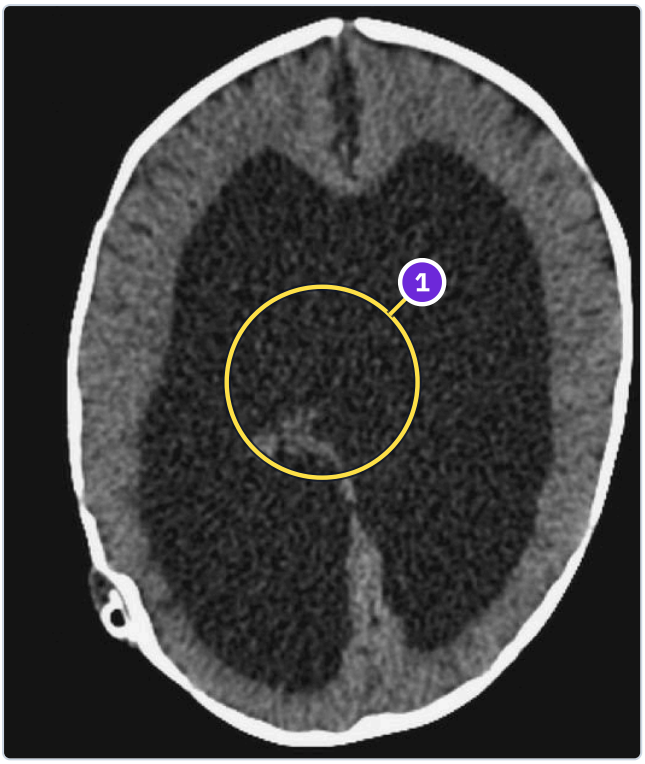



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 75

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ventrículos dilatados

**DIAGNÓSTICO**

### Hidrocefalia

*Ventrículos muy dilatados.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hidrocefalia tras HSA: drenaje ventricular.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2.008 | Hemorragia subaracnoídea | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg No requiere |
| 1.10.2.009 | Hipertensión endocraneana | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Atrofia: surcos también amplios.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 25**
Tema 10.4

**Clase 10.4** en video

## 18 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

FONDO DE OJO

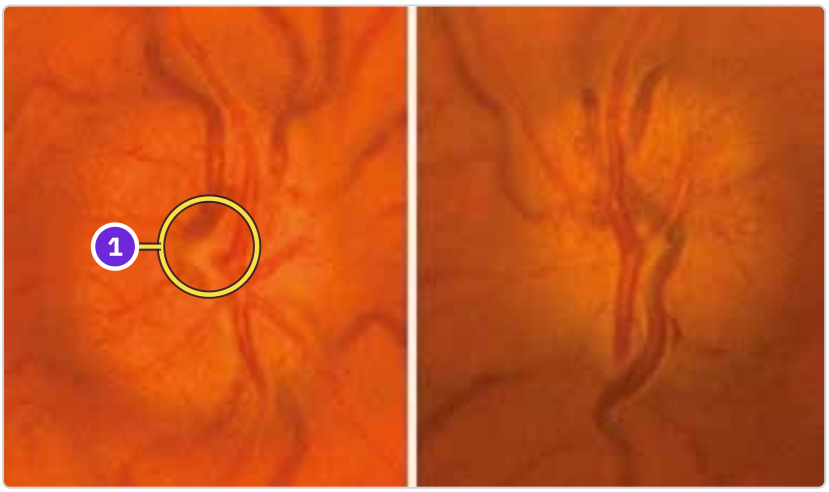



Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 88

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Borde papilar borroso

**DIAGNÓSTICO**

### Papiledema

*Papila de bordes borrosos y elevada.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hipertensión endocraneana: neuroimagen antes de la punción lumbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.1.019 | Síndrome de hipertensión endocraneana | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg No requiere |

**SE CONFUNDE CON…**

Pseudopapiledema: drusas.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2025 · P169** «Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea…» → **Síndrome de hipertensión endocraneana**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 31**
Tema 10.5

**Clase 10.5** en video

## 19 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

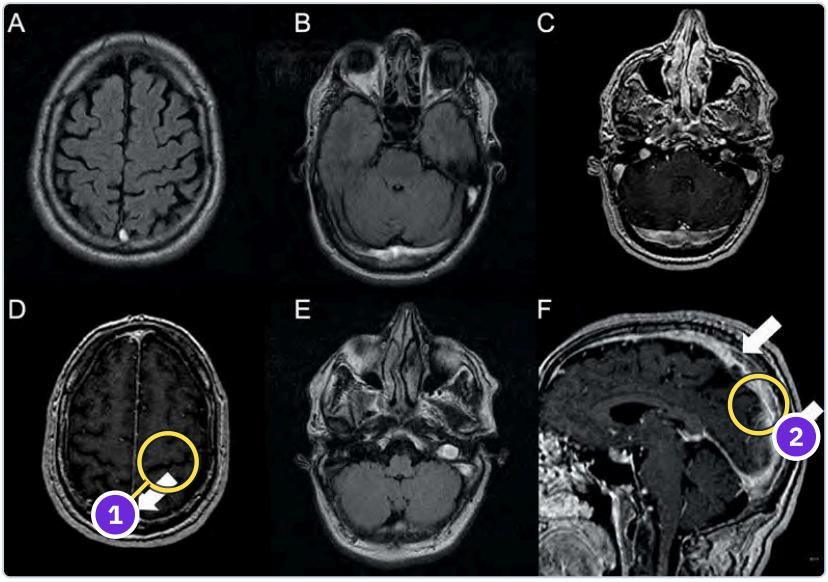



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 64

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Delta vacío
2. Seno trombosado

**DIAGNÓSTICO**

### Trombosis del seno sagital

*Signo del delta vacío y seno trombosado (flechas).*

**CONDUCTA INICIAL**

Anticoagulación plena aunque haya hemorragia.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.4.002` **Resonancia magnética de encéfalo y columna**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Seno normal: se rellena.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 31** Tema 10.5

**Clase 10.5** en video

## 20 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

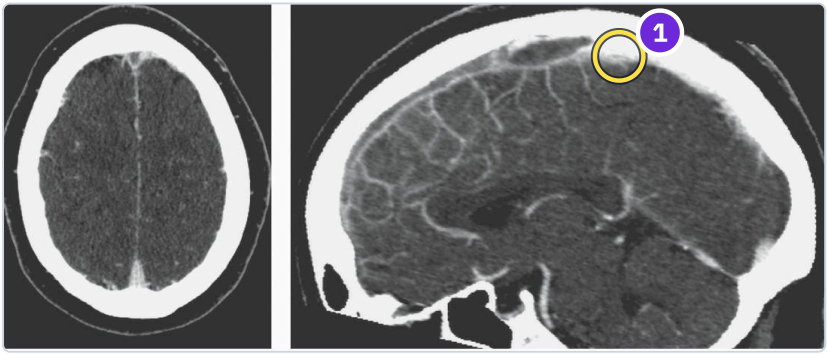



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 100

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Seno sin relleno

**DIAGNÓSTICO**

### Defecto de relleno venoso

*El seno no se rellena en la fase venosa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Angio-RM venosa: examen de elección.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Hipoplasia de seno: variante normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 31** Tema 10.5

**Clase 10.5** en video

## 21 TEMA 10.6 · MIGRAÑA (FISIOPATOLOGÍA, CRITERIOS IHS, TRIPTANES Y PROFILAXIS) Y CEFALEA TENSIONAL

ESQUEMA

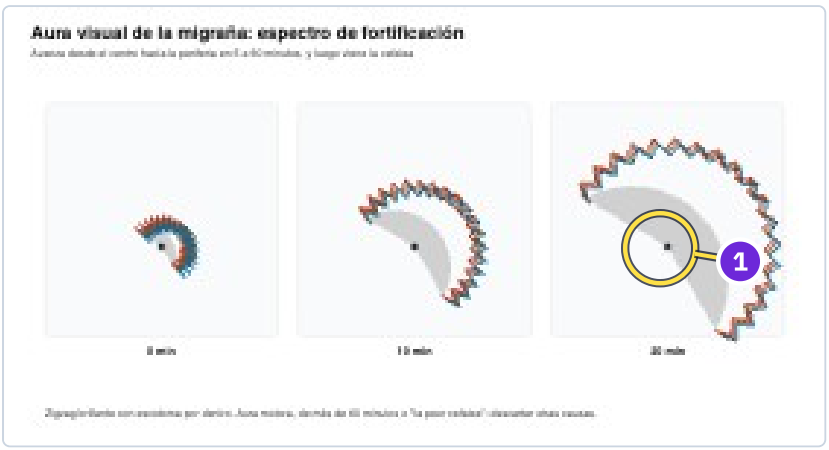



Imagen: Dibujo propio (esquema)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Espectro en zigzag

**DIAGNÓSTICO**

### Aura visual: espectro de fortificación

*Zigzag brillante que se expande en 5–60 minutos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Migraña con aura: evitar estrógenos.

1.10.1.012 Migraña

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

AIT: déficit súbito sin progresión.

PREGUNTA REAL

**Julio 2013 · P180** «Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea...» → **Migraña clásica**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 38**
Tema 10.6

**Clase 10.6** en video

## 22 TEMA 10.7 · CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) Y NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

FOTO CLÍNICA

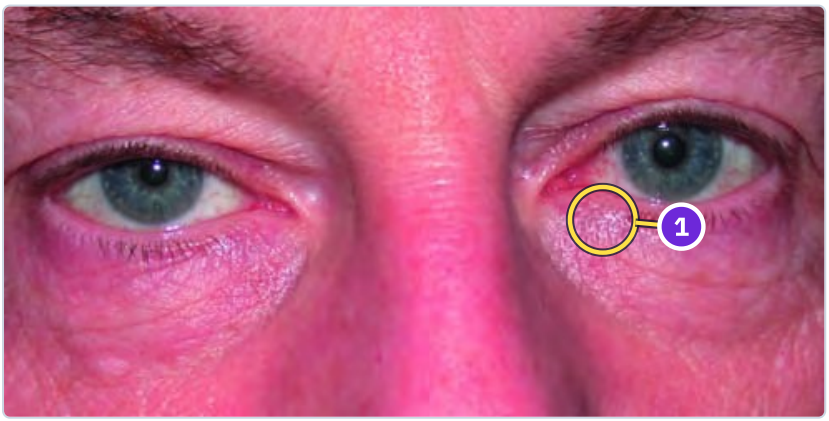



Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., Fig. 19.35A

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ptosis y miosis

**DIAGNÓSTICO**

### Síndrome de Horner en la cefalea en racimos

*Ptosis y miosis del lado del dolor.*

**CONDUCTA INICIAL**

Crisis: oxígeno al 100% o sumatriptán SC; prevención con verapamilo.

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Horner por disección carotídea: dolor cervical.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 45**
Tema 10.7

**Clase 10.7** en video

## 23 TEMA 10.7 · CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) Y NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

ESQUEMA

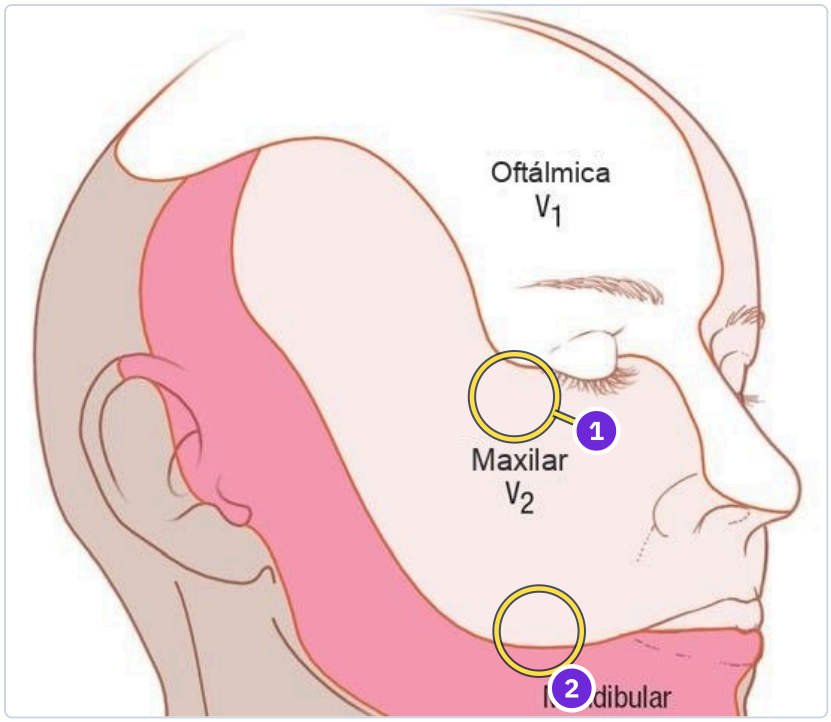



Imagen: Fitzpatrick Dermatología, p. 2330

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. V2
2. V3

**DIAGNÓSTICO**

### Ramas del trigémino

*V1 oftálmica, V2 maxilar y V3 mandibular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Neuralgia del trigémino: carbamazepina.

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Dolor dental.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2016 · P94** «Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que…» → **Pregabalina**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 45** Tema 10.7

**Clase 10.7** en video

## 24 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

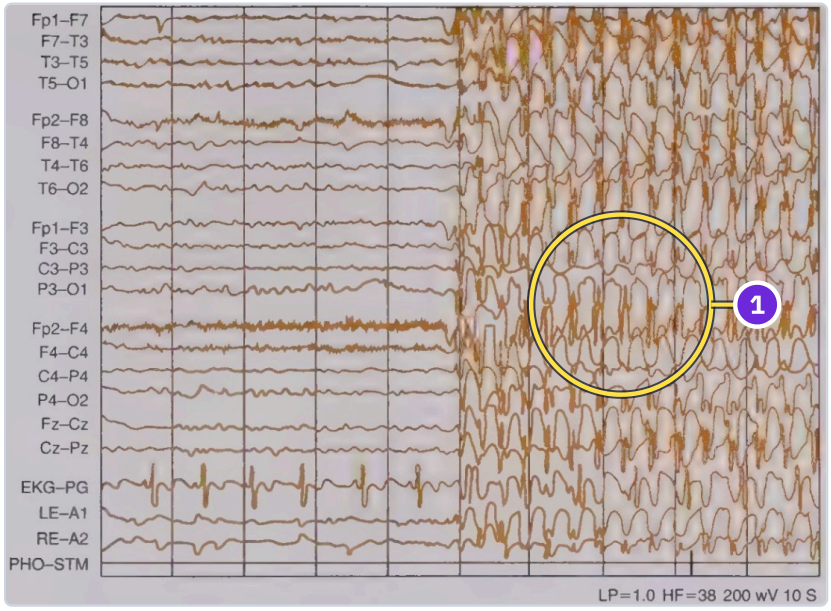



Imagen: Zitelli & Davis, Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 637

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Punta-onda

**DIAGNÓSTICO**

### Crisis de ausencia en el EEG

*Punta-onda generalizada a 3 Hz.*

**CONDUCTA INICIAL**

Etosuximida o ácido valproico.

1.10.1.007 Epilepsia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.4.005 Electroencefalograma — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Crisis focal: actividad localizada.

**PREGUNTA REAL** *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 49** Tema 10.8

**Clase 10.8** en video

## 25 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

FOTO CLÍNICA

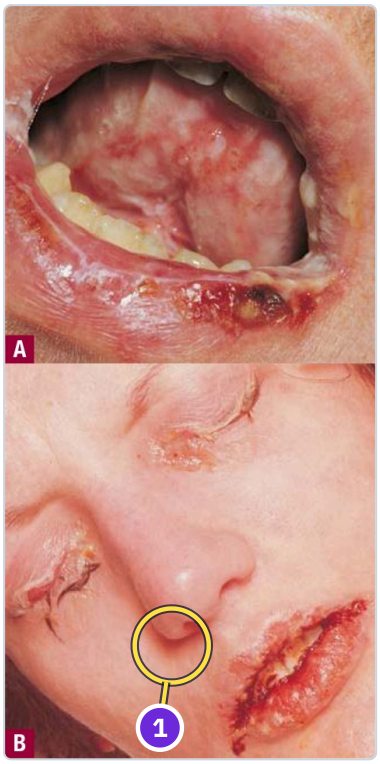



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 390

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Erosiones labiales

**DIAGNÓSTICO**

### Stevens-Johnson por anticonvulsivantes

*Erosiones de los labios y mucosas.*

**CONDUCTA INICIAL**

Suspender el fármaco y hospitalizar.

1.10.1.007 Epilepsia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Eritema multiforme: dianas acrales.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2017 · P133** «Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto,...» → **Epilepsia mioclónica juvenil**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 49**
Tema 10.8

**Clase 10.8** en video

## 26 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

FOTO CLÍNICA

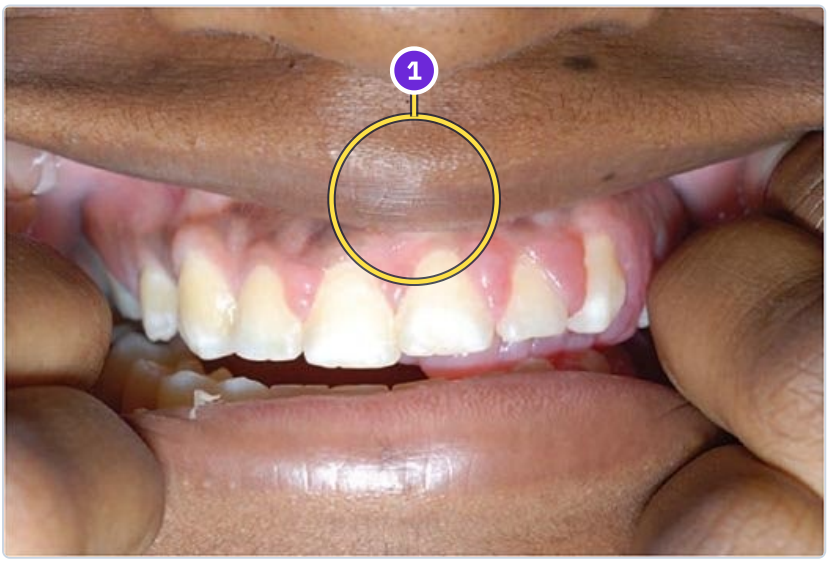



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 174

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Encías hiperplásicas

**DIAGNÓSTICO**

### Hiperplasia gingival por fenitoína

*Encías engrosadas.*

**CONDUCTA INICIAL**

Efecto adverso crónico: higiene oral.

1.10.1.007 Epilepsia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Leucemia: con citopenias.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 49**
Tema 10.8

**Clase 10.8** en video

## 27 TEMA 10.10 · PRIMERA CRISIS CONVULSIVA DEL ADULTO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON SÍNCOPE

FOTO CLÍNICA

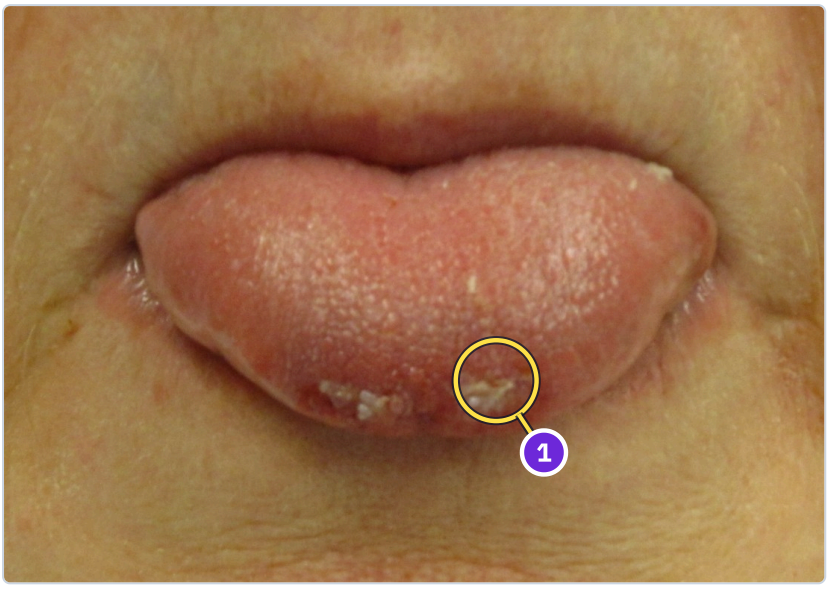



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Mordedura lateral

**DIAGNÓSTICO**

### Mordedura lateral de la lengua

*Herida en el borde lateral tras una crisis tónico-clónica.*

**CONDUCTA INICIAL**

Orienta a crisis convulsiva y no a síncope.

1.10.2.003 **Crisis convulsiva**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Síncope: si hay mordedura, es en la punta.

**PREGUNTA REAL**

**Diciembre 2022 · P166** «Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que…» → **Crisis focal secundariamente generalizado**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 60** Tema 10.10

**Clase 10.10** en video

## 28 TEMA 10.11 · ENFERMEDAD DE PARKINSON

ESQUEMA

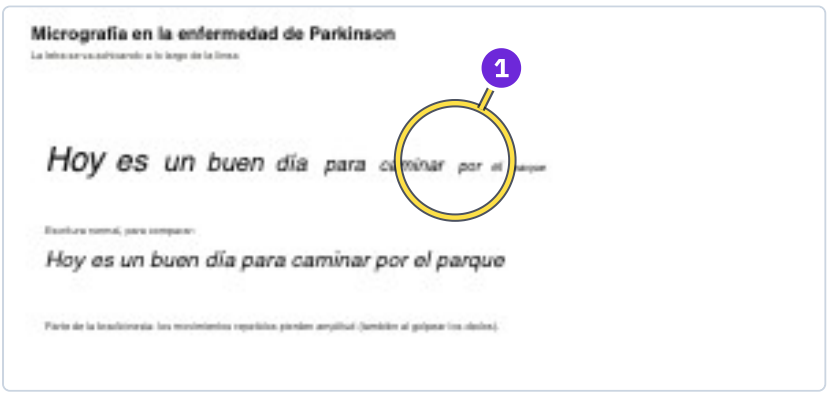



Imagen: Dibujo propio (esquema)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Letra que se achica

**DIAGNÓSTICO**

### Micrografía

*La letra se achica a lo largo de la línea.*

**CONDUCTA INICIAL**

Bradicinesia del Parkinson.

1.10.1.006 **Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Temblor esencial: letra temblorosa, no pequeña.

**PREGUNTA REAL**

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 67** Tema 10.11

**Clase 10.11** en video

## 29 TEMA 10.11 · ENFERMEDAD DE PARKINSON

ESQUEMA

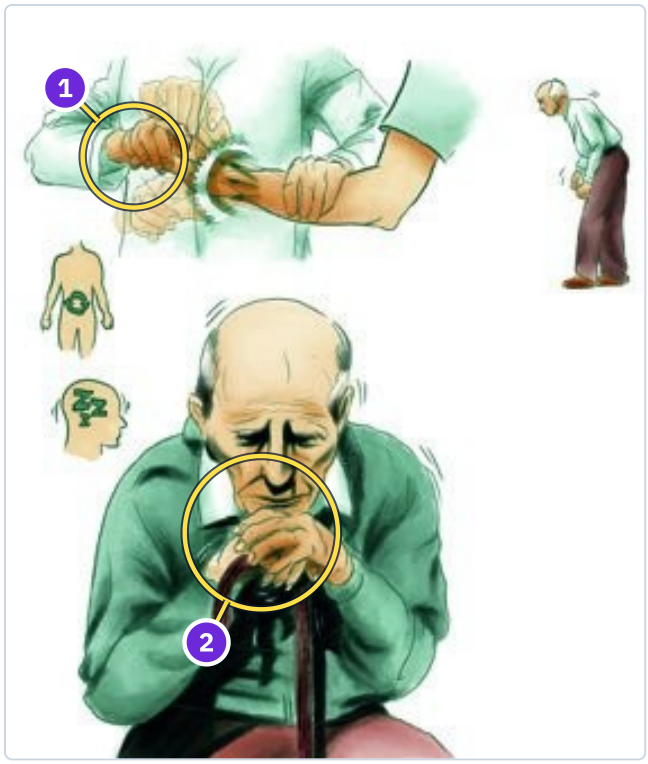



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 54

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Temblor de reposo
2. Tronco flectado

**DIAGNÓSTICO**

### Postura parkinsoniana

*Flexión del tronco, hipomimia y temblor en reposo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Levodopa-carbidopa.

1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Parkinsonismo por fármacos: simétrico.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2018 · P22** «Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha…» → **Enfermedad de Parkinson**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 67**
Tema 10.11

**Clase 10.11** en video

## 30 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

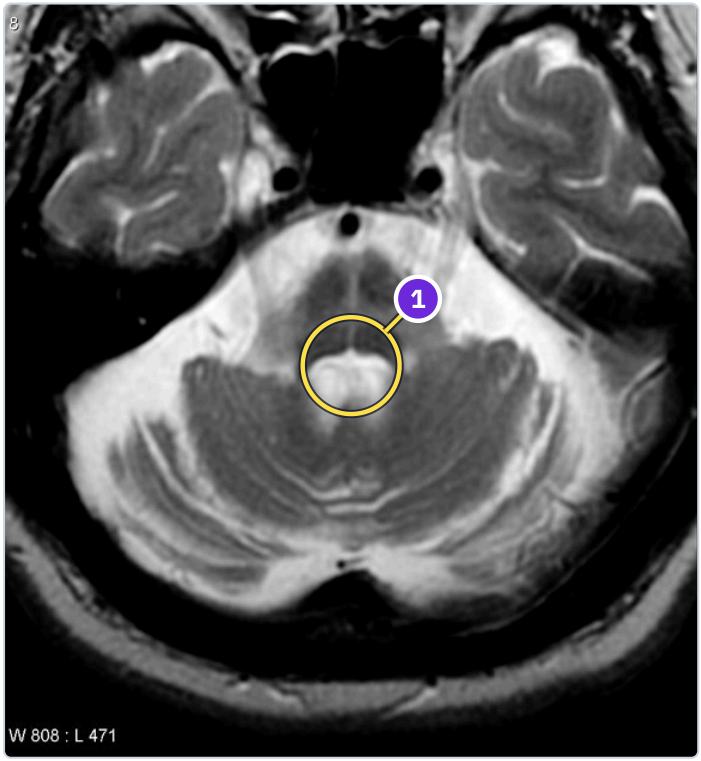



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Cruz en la protuberancia

**DIAGNÓSTICO**

### Signo de la cruz caliente

*Cruz hiperintensa en la protuberancia atrófica.*

**CONDUCTA INICIAL**

Atrofia multisistémica: mala respuesta a levodopa.

1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Parkinson: RM normal.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 73**
Tema 10.12

**Clase 10.12** en video

## 31 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

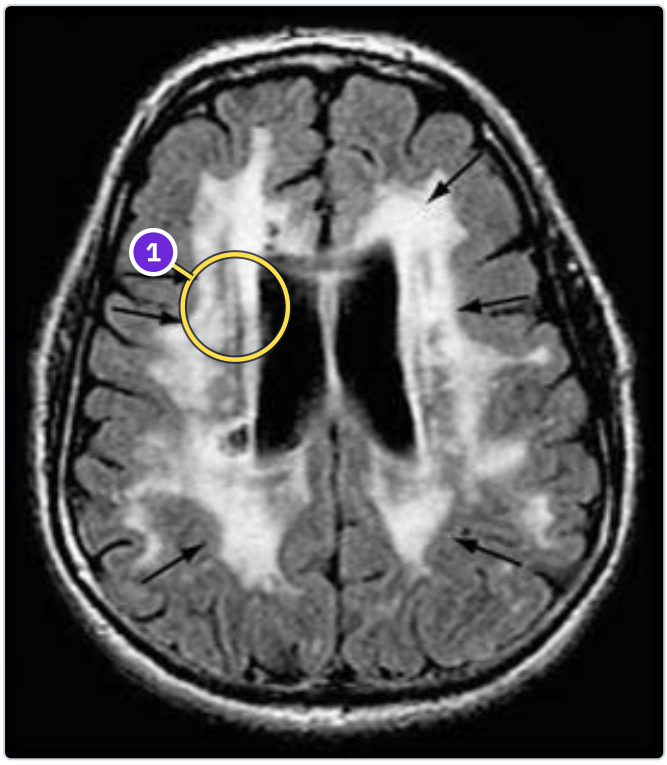



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 234

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Leucoaraiosis

**DIAGNÓSTICO**

### Leucoaraiosis e infartos lacunares

*Hiperseñales de la sustancia blanca (flechas).*

**CONDUCTA INICIAL**

Parkinsonismo vascular: control de factores de riesgo.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.1.006 | Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere |
| 1.10.1.005 | Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Esclerosis múltiple: lesiones ovoideas periventriculares.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 73** Tema 10.12

**Clase 10.12** en video

## 32 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

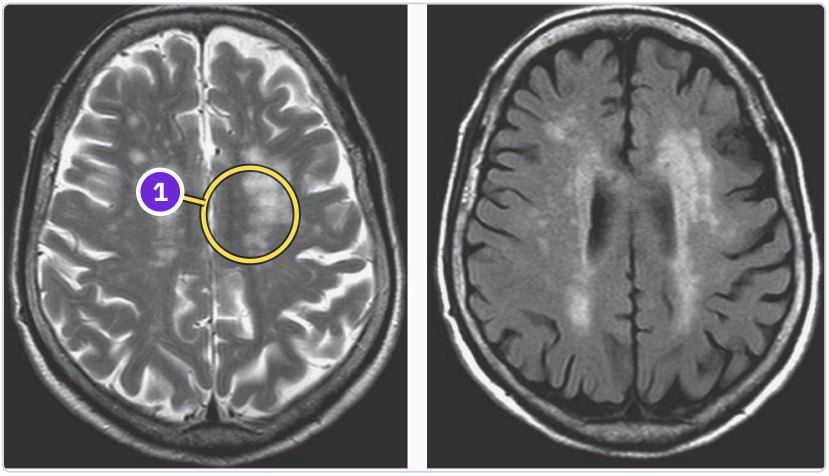



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 104

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Sustancia blanca alterada

**DIAGNÓSTICO**

### Leucoaraiosis en RM FLAIR

*Hiperseñales confluentes periventriculares.*

**CONDUCTA INICIAL**

Demencia vascular: progresión escalonada.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.1.005 | Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Alzheimer: atrofia hipocampal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 73** Tema 10.12

**Clase 10.12** en video

## 33 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

ESQUEMA

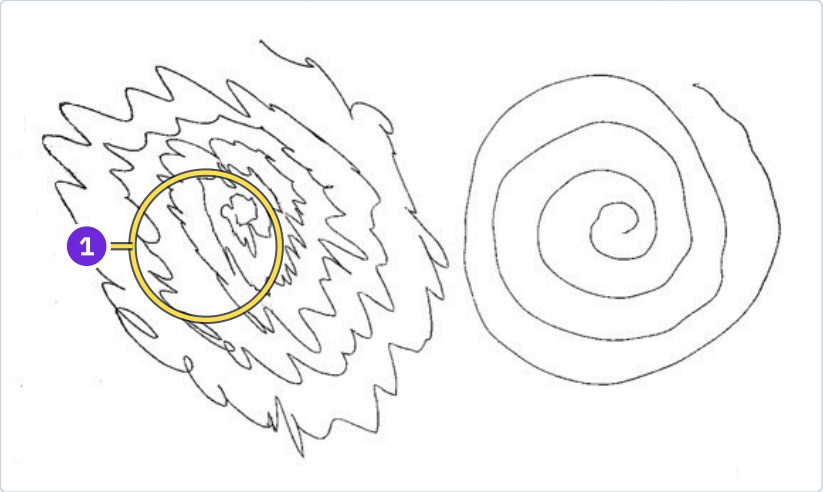



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trazo tembloroso

DIAGNÓSTICO

### Espiral con temblor

*Oscilación en todo el trazo.*

CONDUCTA INICIAL

Temblor esencial: propranolol o primidona.

1.10.1.026 **Temblor esencial**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Parkinson: temblor de reposo.

PREGUNTA REAL

**Julio 2024 · P85** «Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa…» → **Propranolol**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

**p. 76**

Tema 10.13

**Clase 10.13** en video

## 34 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

ESQUEMA

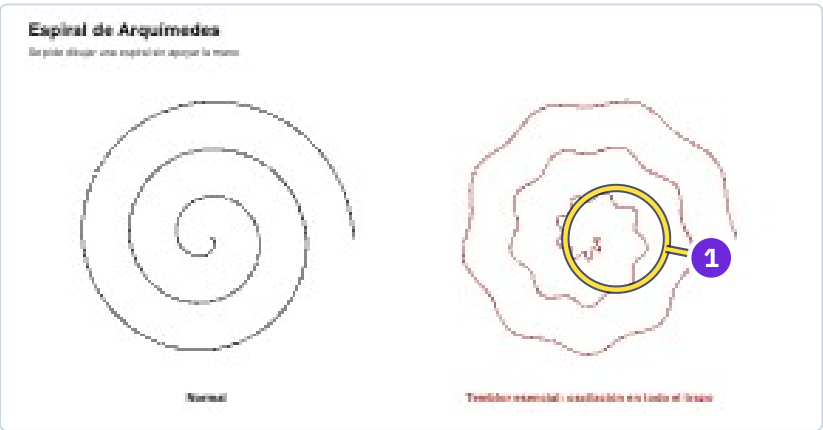



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espiral alterada

DIAGNÓSTICO

### Espiral de Arquímedes

*Normal vs temblor esencial.*

CONDUCTA INICIAL

Mejora con alcohol: típico del esencial.

1.10.1.026 **Temblor esencial**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Distonía: postura anormal.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

**p. 76**

Tema 10.13

**Clase 10.13** en video

## 35 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

FOTO CLÍNICA

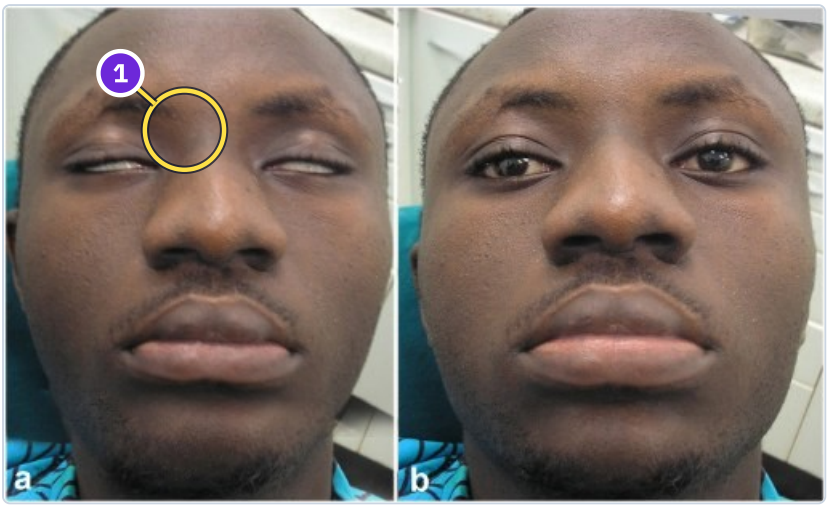



Imagen: Open-i (NLM), CC BY

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ojos desviados arriba

**DIAGNÓSTICO**

### Crisis oculógira

*Mirada desviada hacia arriba de forma sostenida.*

**CONDUCTA INICIAL**

Distonía aguda por metoclopramida: biperideno.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.2.005 | Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos) | Dx Específico · Tx Completo · Seg No requiere |
| 1.10.2.010 | Movimientos anormales inducidos por fármacos | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere |

**SE CONFUNDE CON…**

Crisis convulsiva: con compromiso de conciencia.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 76**
Tema 10.13

**Clase 10.13** en video

## 36 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

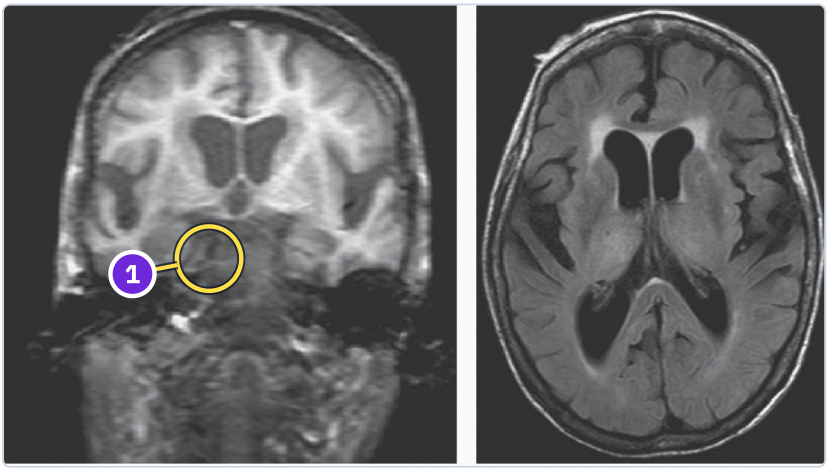



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 102

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Hipocampo atrófico

**DIAGNÓSTICO**

### Atrofia hipocampal

*Hipocampos reducidos en la RM coronal.*

**CONDUCTA INICIAL**

Alzheimer: inhibidores de colinesterasa.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.1.005 | Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.07.1.003 | Demencia | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Envejecimiento normal: atrofia leve.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2022 · P69** «Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se…» → **Demencia por cuerpos de Lewy**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 82**
Tema 10.14

**Clase 10.14** en video

## 37 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

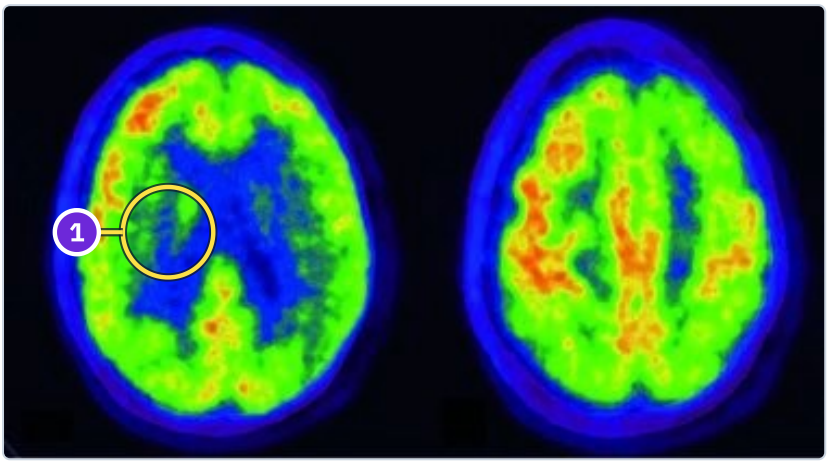



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 29

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hipometabolismo

**DIAGNÓSTICO**

### PET-FDG en Alzheimer

*Hipometabolismo parietotemporal.*

**CONDUCTA INICIAL**

Apoya el diagnóstico en casos dudosos.

| | |
|---|---|
| 1.10.1.005 | Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Frontotemporal: hipometabolismo frontal.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 82** Tema 10.14

**Clase 10.14** en video

## 38 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

ESQUEMA

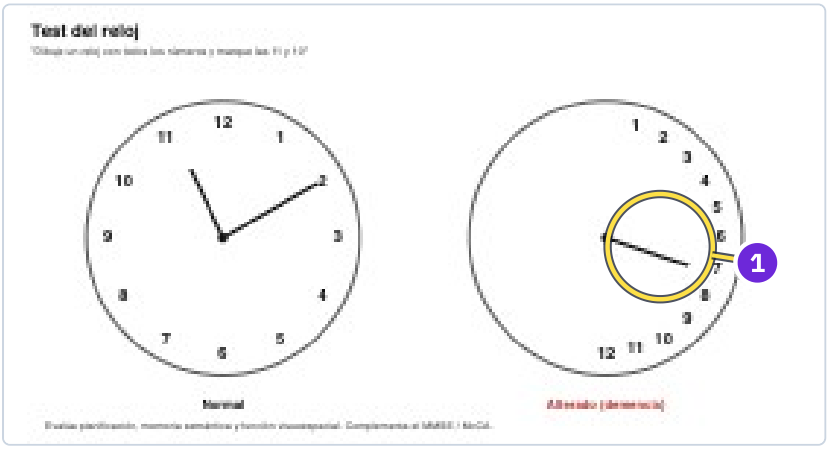



Imagen: Dibujo propio (esquema)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Reloj alterado

**DIAGNÓSTICO**

### Test del reloj

*Normal vs alterado en la demencia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Junto al MMSE o MoCA.

| | |
|---|---|
| 1.10.5.003 | Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-Mental) — examen/procedimiento |
| 1.07.5.002 | Valoración cognitiva — examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Depresión: rendimiento variable.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2025 · P25** «Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a que presenta olvidos frecuentes. Su acompañante refiere que la paciente ha olvidado…» → **Mini-Mental State Examination (MMSE)**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 79** Tema 10.14

**Clase 10.14** en video

## 39 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

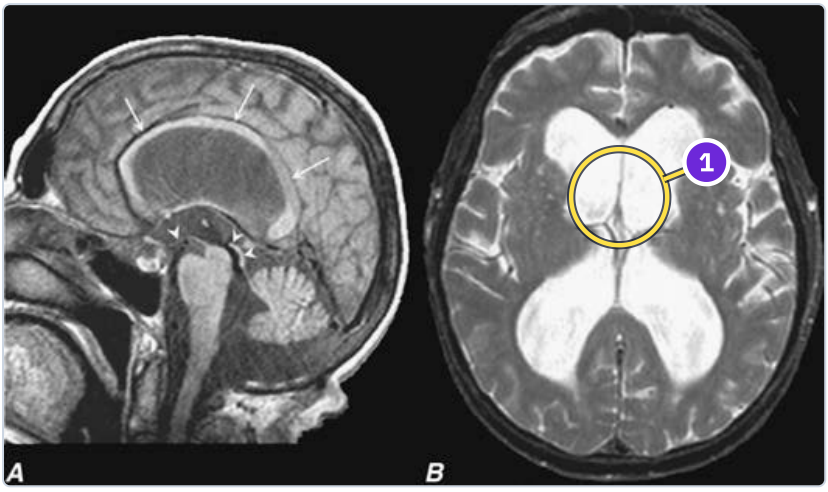



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 235

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ventrículos dilatados

**DIAGNÓSTICO**

### Hidrocefalia normotensiva

*Ventrículos grandes desproporcionados a la atrofia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Marcha magnética + incontinencia + demencia: punción evacuadora y válvula.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.1.003 | Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere |
| 1.10.1.005 | Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Atrofia: surcos amplios.

PREGUNTA REAL

**Julio 2025 · P104** «Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de...» → **Hematoma subdural crónico**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 81**
Tema 10.14

**Clase 10.14** en video

## 40 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

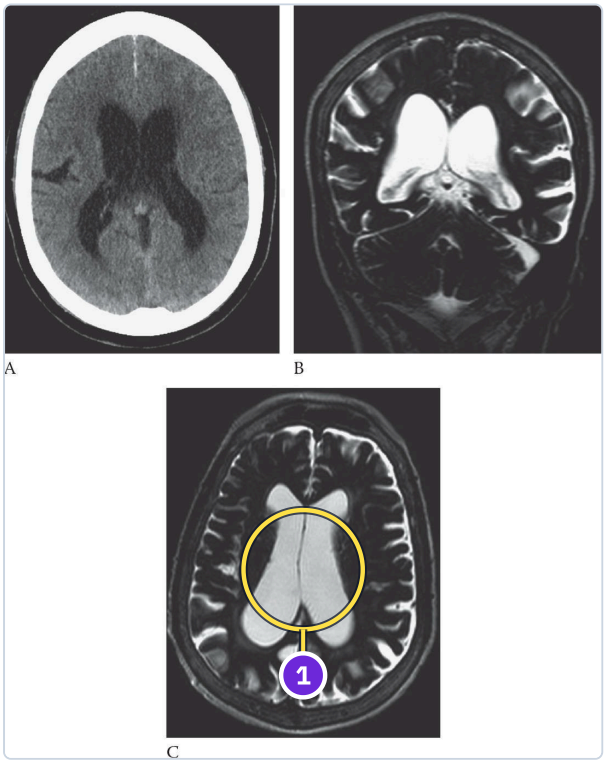



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 106

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ventrículos dilatados

**DIAGNÓSTICO**

### Hidrocefalia normotensiva en TC y RM

*Ventriculomegalia en tres cortes.*

**CONDUCTA INICIAL**

Demencia potencialmente reversible.

| | | |
|---|---|---|
| 1.10.1.003 | Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere |

**SE CONFUNDE CON…**

Alzheimer: ventrículos por atrofia.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 81**
Tema 10.14

**Clase 10.14** en video

## 41 TEMA 10.15 · DEMENCIA VASCULAR, DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY Y DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

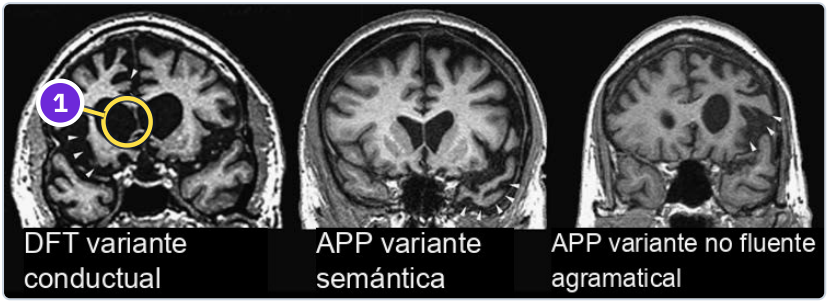



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 3420

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Atrofia frontotemporal

**DIAGNÓSTICO**

### Demencia frontotemporal

*Atrofia en filo de cuchillo frontal y temporal anterior.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cambios de conducta precoces.

1.10.1.005 **Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Alzheimer: empieza por la memoria.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 88** Tema 10.15

**Clase 10.15** en video

## 42 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA

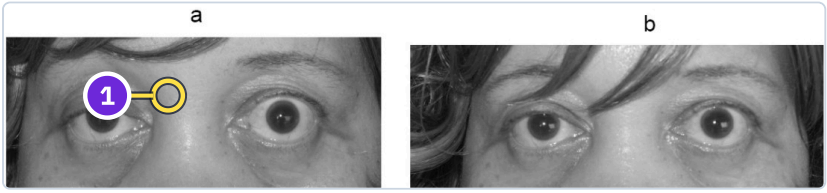



Imagen: Wikimedia Commons

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ptosis

**DIAGNÓSTICO**

### Ptosis miasténica: antes y después

*La ptosis mejora tras el reposo o el hielo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Anti-AChR y EMG con estimulación repetitiva; buscar timoma.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Horner: ptosis con miosis.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P74** «Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace un mes. Además,...» → **Miastenia gravis**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 103** Tema 10.17

**Clase 10.17** en video

## 43 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 851

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ptosis

**DIAGNÓSTICO**

### Ptosis miasténica

*Ptosis asimétrica que empeora en la tarde.*

**CONDUCTA INICIAL**

Piridostigmina.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

III par: con midriasis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 101** Tema 10.17

**Clase 10.17** en video

## 44 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 851

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Hielo sobre el párpado

**DIAGNÓSTICO**

### Test del hielo

*Hielo 2–3 minutos sobre el párpado.*

**CONDUCTA INICIAL**

Positivo si mejora 2 mm o más.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Ptosis senil: no mejora.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 101** Tema 10.17

**Clase 10.17** en video

## 45 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FOTO CLÍNICA

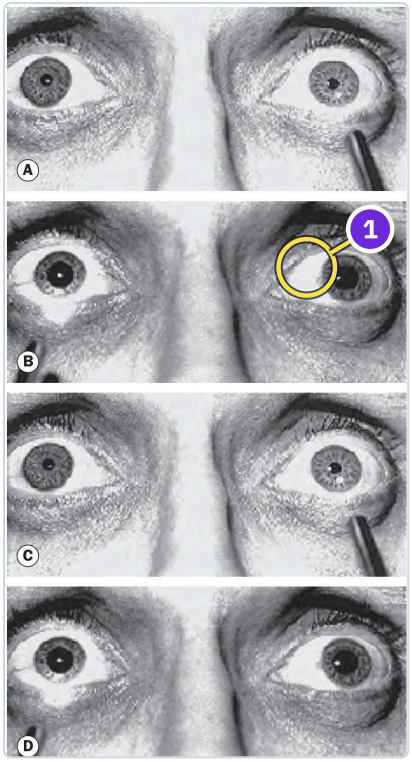



Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 820

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Pupila que se dilata

**DIAGNÓSTICO**

### Defecto pupilar aferente relativo

*Al iluminar el ojo enfermo, ambas pupilas se dilatan.*

**CONDUCTA INICIAL**

Neuritis óptica: RM con contraste.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Anisocoria: pupilas de distinto tamaño en reposo.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 107
Tema 10.18

**Clase 10.18** en video

## 46 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

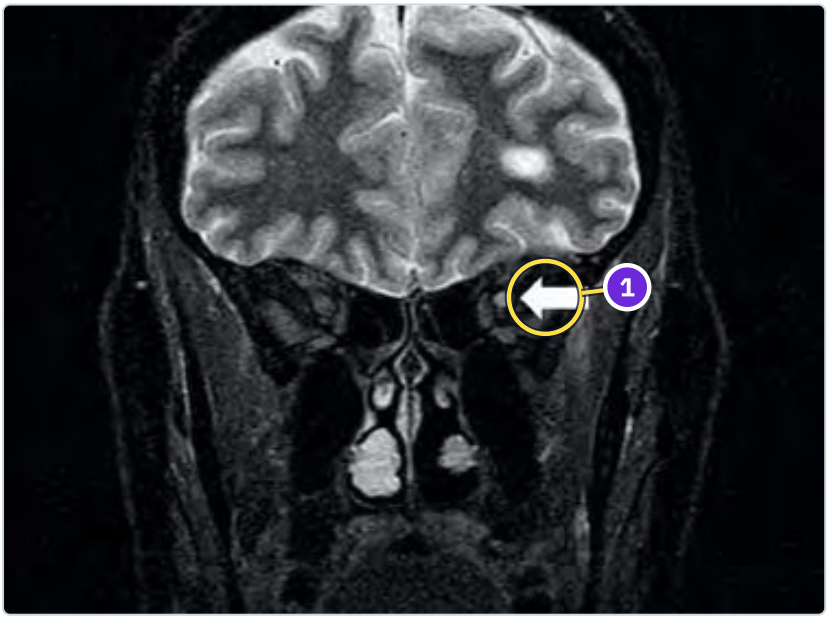



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 74

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Nervio óptico

**DIAGNÓSTICO**

### Neuritis óptica en la RM

*Hiperintensidad del nervio óptico (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Bolos de metilprednisolona; estudiar esclerosis múltiple.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.4.002 **Resonancia magnética de encéfalo y columna**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Neuropatía isquémica: adulto mayor, súbita.

PREGUNTA REAL

**Julio 2019 · P104** «Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega…» → **Esclerosis múltiple**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 107
Tema 10.18

**Clase 10.18** en video

## 47 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 843

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Falta de aducción

**DIAGNÓSTICO**

### Oftalmoplejía internuclear

*Un ojo no aduce y el otro tiene nistagmo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Joven: esclerosis múltiple.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

VI par: falla la abducción.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 107** Tema 10.18

**Clase 10.18** en video

## 48 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4747

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Mielitis extensa

**DIAGNÓSTICO**

### Neuromielitis óptica

*Mielitis de 3 o más cuerpos vertebrales.*

**CONDUCTA INICIAL**

Anti-acuaporina 4.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

EM: lesiones medulares cortas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 111** Tema 10.18

**Clase 10.18** en video

## 49 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Otorrinolaringología 14.ª ed., p. 45

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ojo que no cierra
2. Comisura caída

**DIAGNÓSTICO**

### Parálisis facial periférica

*Toda la hemicara: no arruga la frente ni cierra el ojo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Bell: prednisona en 72 h y protección ocular.

1.10.1.016 Parálisis facial periférica
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Central: respeta la frente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 116**
Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 50 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

ESQUEMA




Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 14

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Frente respetada

**DIAGNÓSTICO**

### Parálisis facial central vs periférica

*La central respeta la frente y el cierre ocular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Central: buscar ACV.

1.10.1.016 Parálisis facial periférica
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Bell: compromete toda la hemicara.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 116**
Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 51 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 736

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Vesículas en la concha

**DIAGNÓSTICO**

### Síndrome de Ramsay Hunt

*Vesículas en la concha con parálisis facial.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aciclovir o valaciclovir más prednisona.

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Otitis externa: sin vesículas ni parálisis.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 116** Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 52 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA

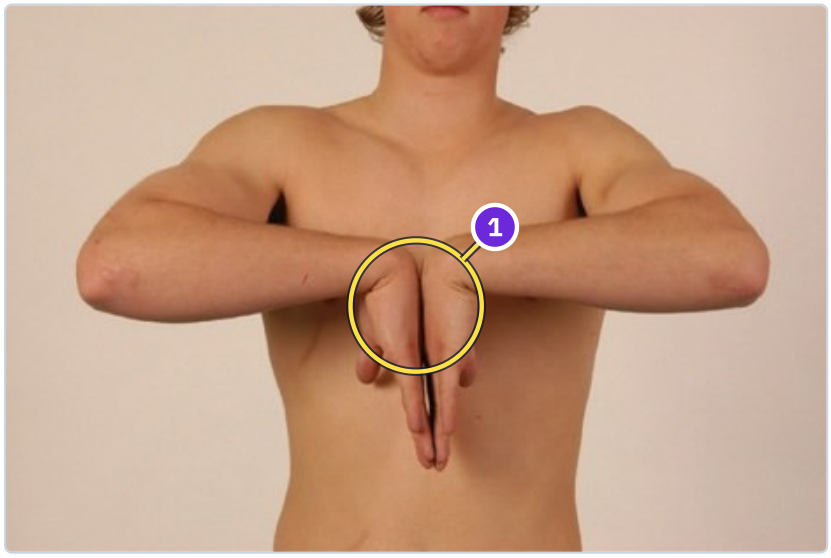



Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 407

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Muñecas en flexión

**DIAGNÓSTICO**

### Maniobra de Phalen

*Flexión forzada de ambas muñecas por 60 segundos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Túnel carpiano: férula nocturna; EMG si hay atrofia.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.11.1.023 **Síndrome de túnel carpiano**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Radiculopatía C6: dolor cervical.

PREGUNTA REAL

**Julio 2024 · P111** «Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en…» → **Síndrome del túnel carpiano**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 115** Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 53 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA

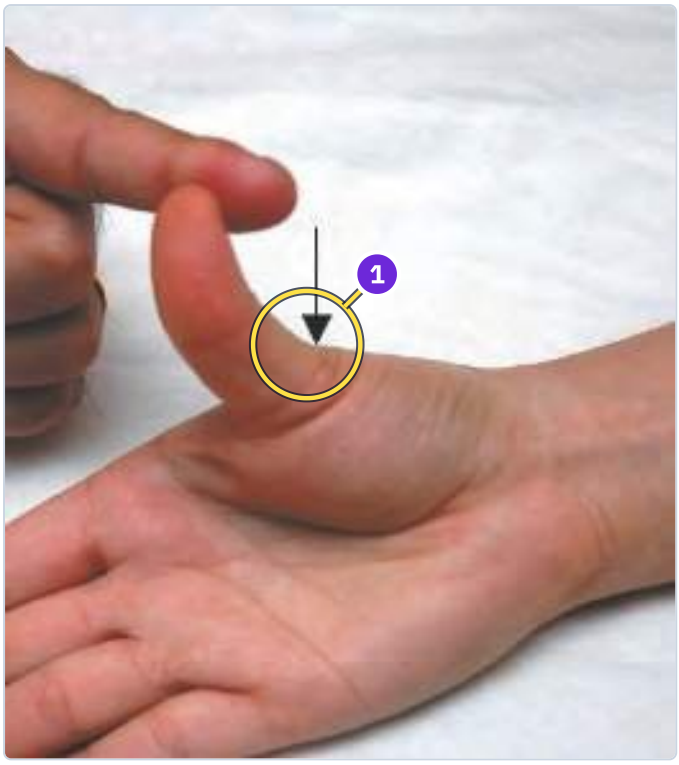



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 467

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Flexión del pulgar

**DIAGNÓSTICO**

### Signo de Froment

*Flexión del pulgar al apretar un papel (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Neuropatía cubital: codo o canal de Guyon.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Túnel carpiano: atrofia tenar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 115** Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 54 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 34.40

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Atrofia interósea

**DIAGNÓSTICO**

### Atrofia de los intrínsecos de la mano

*Atrofia del primer interóseo dorsal.*

**CONDUCTA INICIAL**

EMG para localizar la lesión.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

ELA: atrofia con fasciculaciones.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 115** Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 55 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas of Clinical Diagnosis (Mir), Fig. 9.136

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Mano caída

**DIAGNÓSTICO**

### Mano caída

*Parálisis del nervio radial.*

**CONDUCTA INICIAL**

Compresión en el canal espiral: suele recuperar.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

ACV: con otros déficits.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 116** Tema 10.19

**Clase 10.19** en video

## 56 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

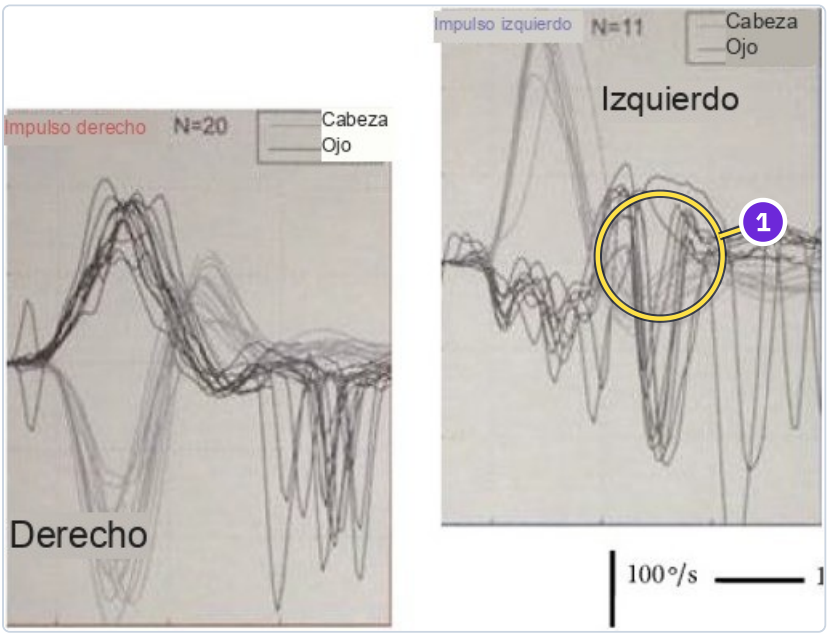



Imagen: Open-i (NLM), CC BY

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Sacadas correctoras

**DIAGNÓSTICO**

### Registro del impulso cefálico

*Movimientos sacádicos correctores al girar la cabeza.*

**CONDUCTA INICIAL**

HINTS: impulso alterado sugiere periférico.

1.10.1.024 **Síndromes vertiginosos centrales**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.1.025 **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Impulso normal en vértigo agudo: sospechar central.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P29** «Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vértigo intenso de inicio súbito hace 2 horas,…» → **Solicitar TAC de cerebro**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 121** Tema 10.20

**Clase 10.20** en video

## 57 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

ESQUEMA

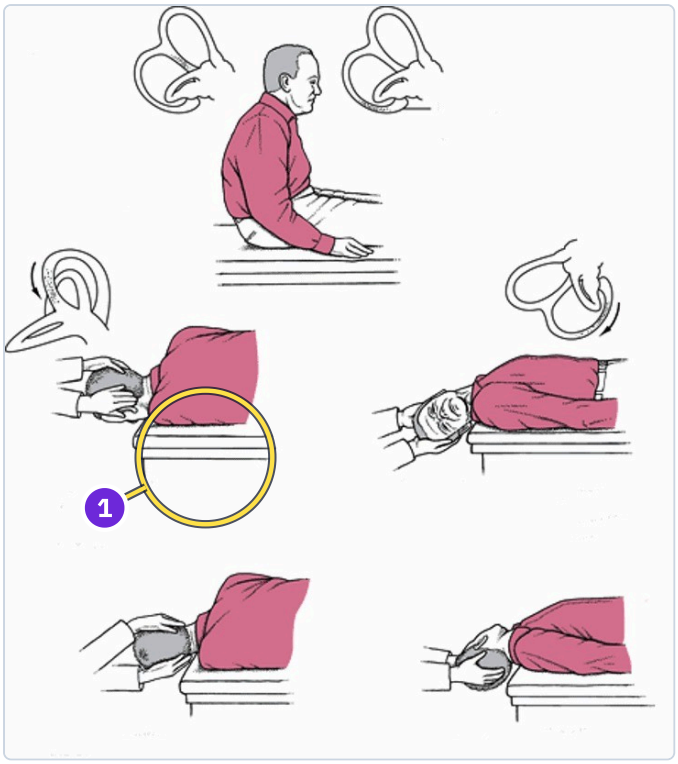



Imagen: Fotografía propia del curso

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Cabeza extendida y girada

**DIAGNÓSTICO**

### Maniobra de Dix-Hallpike

*De sentado a acostado con la cabeza girada 45° y extendida.*

**CONDUCTA INICIAL**

VPPB: nistagmo torsional con latencia.

1.10.1.025 **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

6.03.2.017 **Síndrome vertiginoso agudo**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Nistagmo central: sin latencia, no se agota.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 121**
Tema 10.20

**Clase 10.20** en video

## 58 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

ESQUEMA

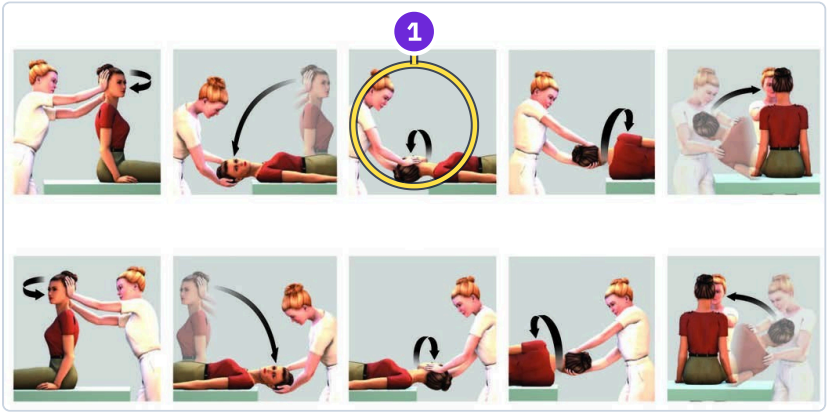



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, p. 202

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Secuencia de giros

**DIAGNÓSTICO**

### Maniobra de Epley

*Giros de la cabeza que llevan los otolitos al vestíbulo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cura el VPPB en la consulta.

1.10.1.025 **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Neuronitis vestibular: no responde a maniobras.

PREGUNTA REAL

**Agosto 2021 · P88** «Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas…» → **Neuronitis vestibular**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 121**
Tema 10.20

**Clase 10.20** en video

## 59 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

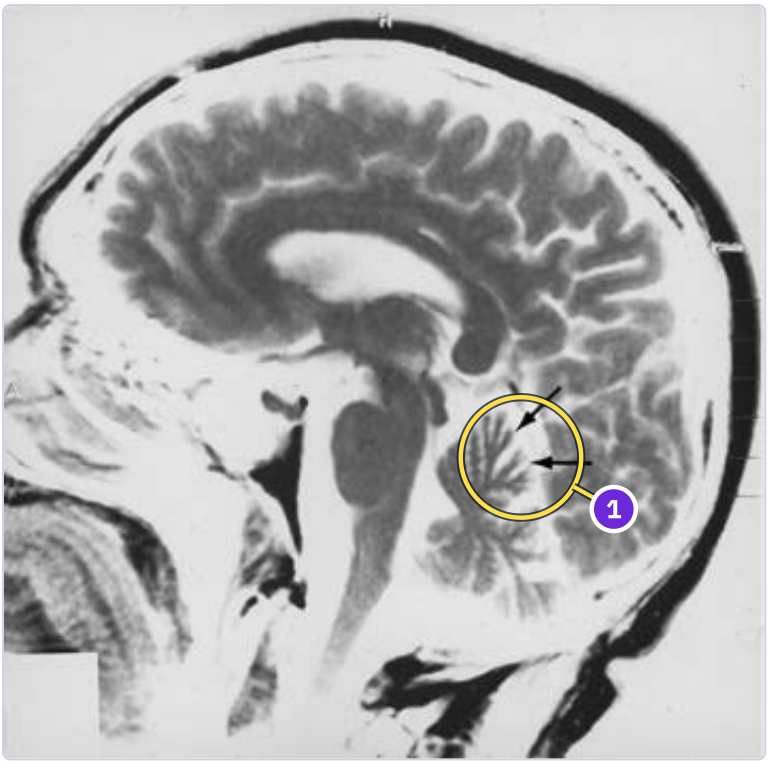



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., Fig. 439-1

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Vermis atrófico

**DIAGNÓSTICO**

### Atrofia cerebelosa

*Surcos del vermis amplios (flechas).*

**CONDUCTA INICIAL**

Ataxia: buscar causa tóxica, paraneoplásica o hereditaria.

`1.10.1.018` **Síndrome atáxico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Tumor de fosa posterior: masa.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2025 · P89** «Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol…» → **Síndrome paraneoplásico**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 120**
Tema 10.20

**Clase 10.20** en video

## 60 TEMA 10.22 · FRAGILIDAD, SARCOPENIA Y VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)

ESQUEMA

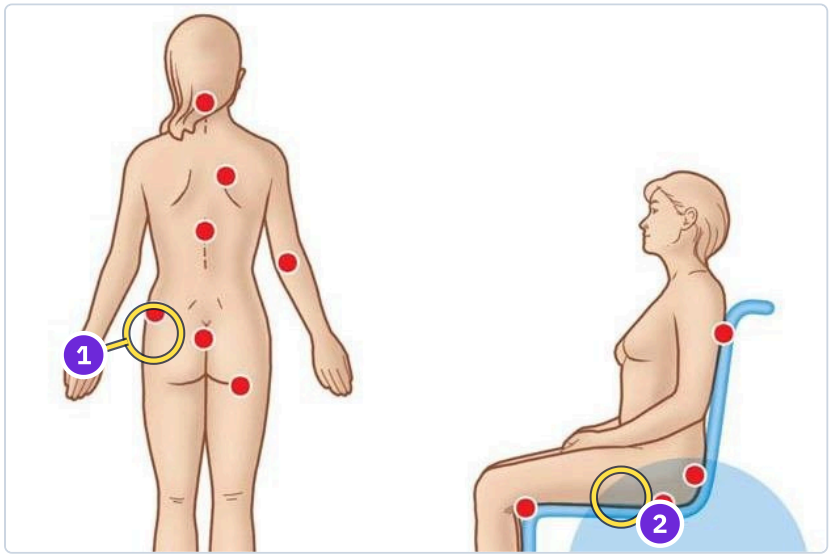



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology, p. 918 (Fig. 99-4)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Sacro
2. Talón

**DIAGNÓSTICO**

### Sitios frecuentes de úlceras por presión

*Sobre prominencias óseas: sacro, trocánteres, talones.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cambios de posición cada 2 horas.

`1.07.1.007` **Escaras o úlceras por presión**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`4.01.1.052` **Escaras**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Úlcera venosa: maléolo medial.

PREGUNTA REAL

**Julio 2019 · P82** «Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico, hace un año, seculado con un síndrome de inmovilidad y marcada…» → **Cambios de posición frecuentes**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
**p. 137**
Tema 10.22

**Clase 10.22** en video

## 61 TEMA 10.22 · FRAGILIDAD, SARCOPENIA Y VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 50 (Fig. 3.9)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Necrosis

**DIAGNÓSTICO**

### Escara sacra necrótica

*Úlcera estadio IV con tejido necrótico.*

**CONDUCTA INICIAL**

Desbridamiento y manejo de la infección.

1.07.1.007 Escaras o úlceras por presión

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Úlcera estadio I: eritema que no blanquea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 137** Tema 10.22

**Clase 10.22** en video

## 62 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

IMAGEN RADIOLÓGICA

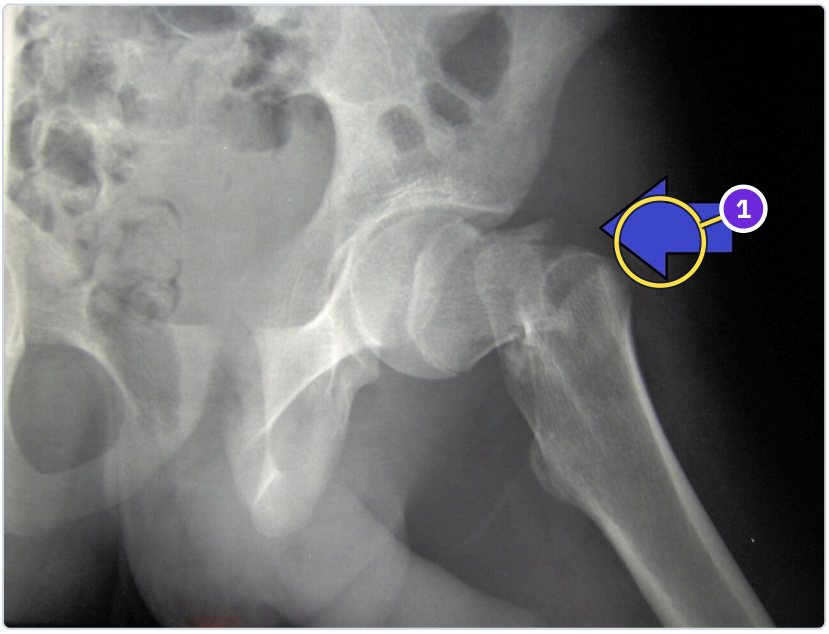



Imagen: Wikimedia Commons

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Fractura

**DIAGNÓSTICO**

### Fractura de cadera

*Fractura del cuello femoral (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Operar antes de 48 horas.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Luxación: cabeza fuera del acetábulo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 142** Tema 10.23

**Clase 10.23** en video

## 63 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

ESQUEMA

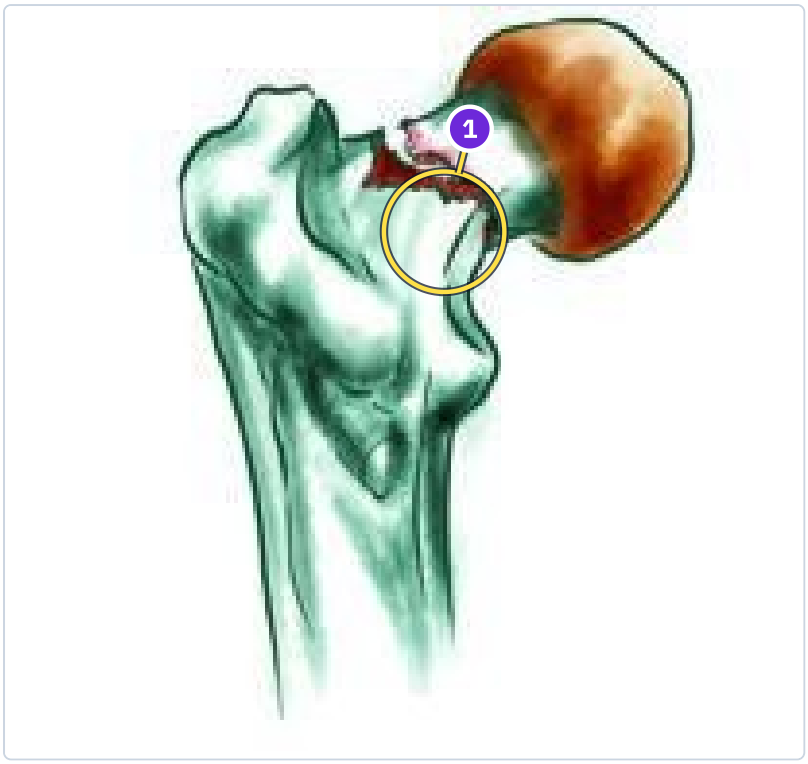



Imagen: Manual CTO Traumatología 14.ª ed., p. 25

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Rasgo subcapital

**DIAGNÓSTICO**

### Fractura subcapital del fémur

*Rasgo en el cuello que compromete la irrigación de la cabeza.*

**CONDUCTA INICIAL**

Intracapsular: riesgo de necrosis avascular.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Extracapsular: buena irrigación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 142** Tema 10.23

**Clase 10.23** en video

## 64 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

ESQUEMA

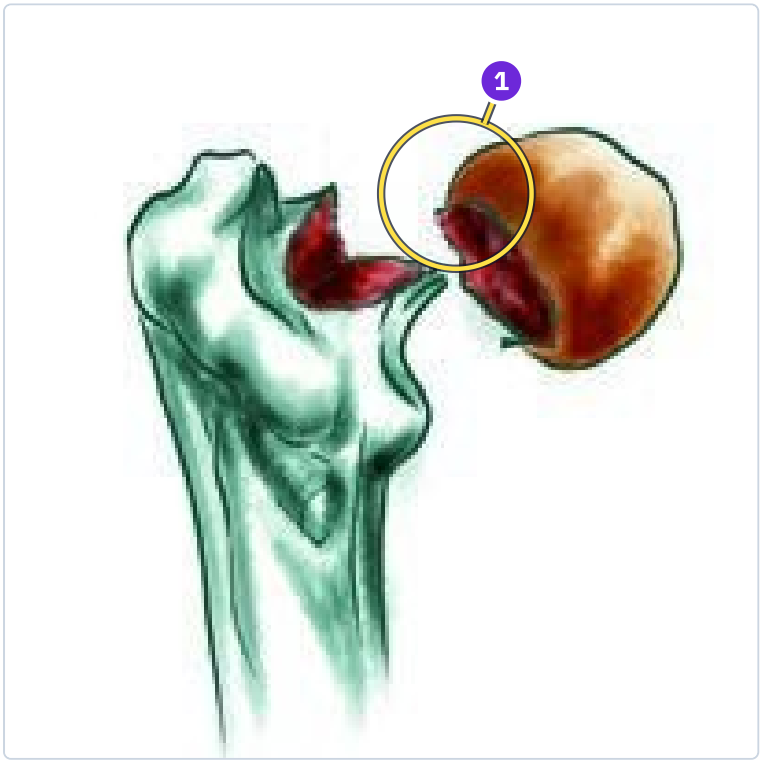



Imagen: Manual CTO Traumatología 14.ª ed., p. 25

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Cabeza desplazada

**DIAGNÓSTICO**

### Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV)

*Cabeza separada del cuello.*

**CONDUCTA INICIAL**

Desplazada en el adulto mayor: prótesis.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

No desplazada: osteosíntesis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 142** Tema 10.23

**Clase 10.23** en video

## 65 TEMA 10.24 · POLIFARMACIA, CRITERIOS DE BEERS / STOPP-START E INCONTINENCIA URINARIA EN LA PERSONA MAYOR

ESQUEMA




Imagen: Dibujo propio (esquema)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Edema por amlodipino

**DIAGNÓSTICO**

### Cascada de prescripción

*Un efecto adverso se trata con otro fármaco.*

**CONDUCTA INICIAL**

Ante un síntoma nuevo, pregunta qué fármaco empezó antes.

1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Enfermedad nueva verdadera.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2019 · P127** «Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. ¿Qué…» → **Glibenclamida**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 146** Tema 10.24

**Clase 10.24** en video

## 66 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

FONDO DE OJO

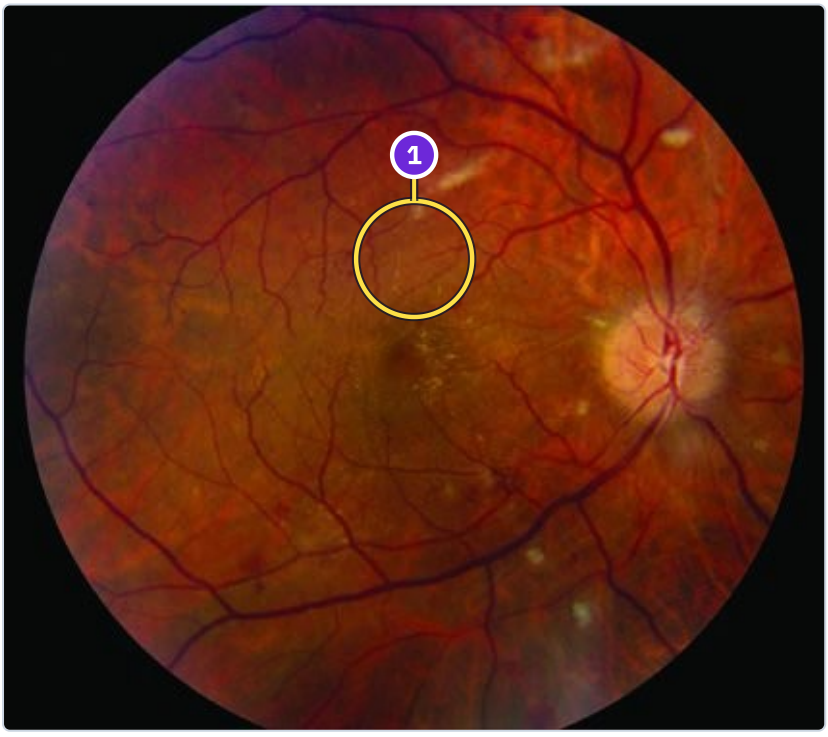



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 32-7, p. 263

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Exudados

**DIAGNÓSTICO**

### Retinopatía hipertensiva

*Exudados y alteraciones de los vasos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Daño de órgano blanco: fondo de ojo, ECG, creatinina.

1.07.1.009 Hipertensión arterial — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Retinopatía diabética: microaneurismas.

**PREGUNTA REAL** *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 150** Tema 10.25

**Clase 10.25** en video

## 67 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

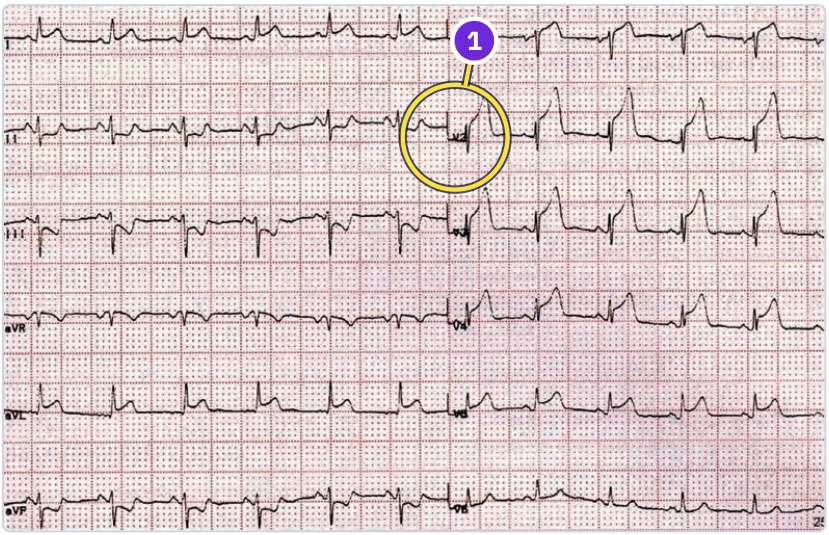



Imagen: ECG from Basics to Essentials, ejemplo 28

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 ST elevado en V1–V4

**DIAGNÓSTICO**

### IAM anterior con SDST

*Supradesnivel del ST en las precordiales.*

**CONDUCTA INICIAL**

ECG < 10 min; angioplastia < 90 min.

1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Pericarditis: ST difuso cóncavo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 150** Tema 10.25

**Clase 10.25** en video

## 68 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

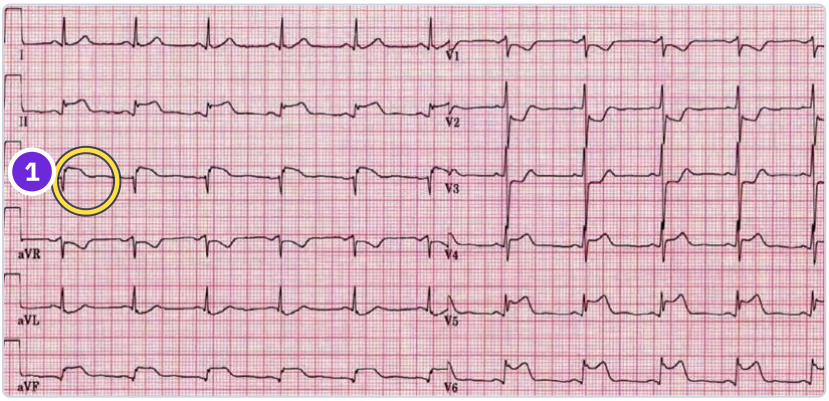



Imagen: ECG from Basics to Essentials, ejemplo 11

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 ST elevado en DIII

**DIAGNÓSTICO**

### IAM inferior con SDST

*Supradesnivel del ST en DII, DIII y aVF.*

**CONDUCTA INICIAL**

Buscar compromiso del VD; evitar nitratos si hay hipotensión.

1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Repolarización precoz.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 150** Tema 10.25

**Clase 10.25** en video

## 69 TEMA 10.26 · CUIDADOS PALIATIVOS, DOLOR CRÓNICO Y FINAL DE VIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.27b (gammagrafía)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Captaciones

**DIAGNÓSTICO**

### Metástasis óseas múltiples

*Captaciones en columna, costillas y pelvis.*

**CONDUCTA INICIAL**

Dolor óseo: AINE, dexametasona, radioterapia y bifosfonatos.

1.08.3.007 **Manejo del dolor crónico y paliativo**

examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Artrosis: captación articular.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 154** Tema 10.26

**Clase 10.26** en video

## 70 TEMA 10.26 · CUIDADOS PALIATIVOS, DOLOR CRÓNICO Y FINAL DE VIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

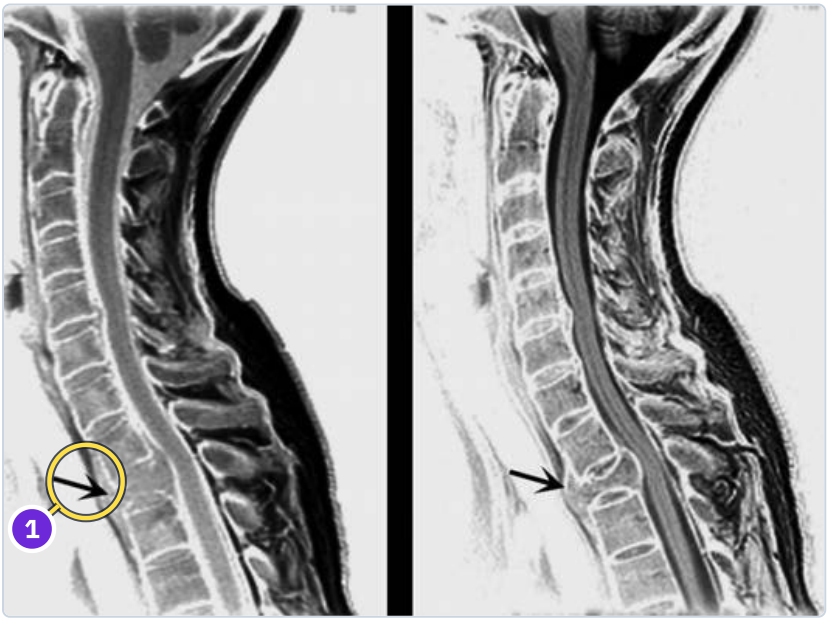



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 442-2 (resonancia sagital)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Compresión

**DIAGNÓSTICO**

### Compresión medular epidural

*Vértebra que comprime la médula (flecha).*

**CONDUCTA INICIAL**

Dexametasona y radioterapia urgente.

1.08.3.008 **Manejo del paciente terminal oncológico**

examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Hernia discal.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P14** «Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis, presenta desde hace un mes tos y regurgitación alimenticia, no ha presentado…» → **Subcutánea**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 154** Tema 10.26

**Clase 10.26** en video

# Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Facial periférica vs central



VS



**A** Parálisis facial periférica

- Toda la hemicara

Ficha n.° 49 · p. 28

**B** Parálisis facial central vs periférica

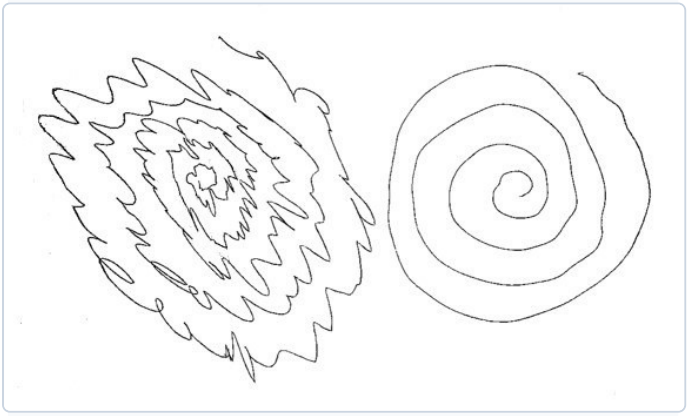
- Respeta la frente

Ficha n.° 50 · p. 28

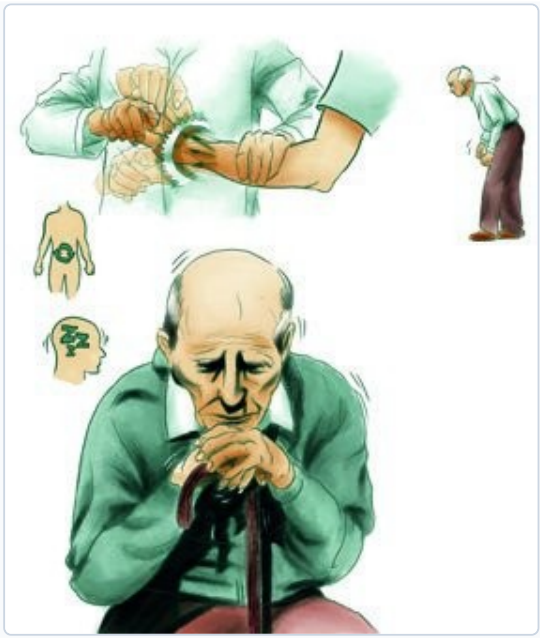
**LA DIFERENCIA** La central obliga a buscar un ACV.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Temblor esencial vs Parkinson



VS



**A** Espiral con temblor

- De acción, bilateral

Ficha n.° 33 · p. 20

**B** Postura parkinsoniana

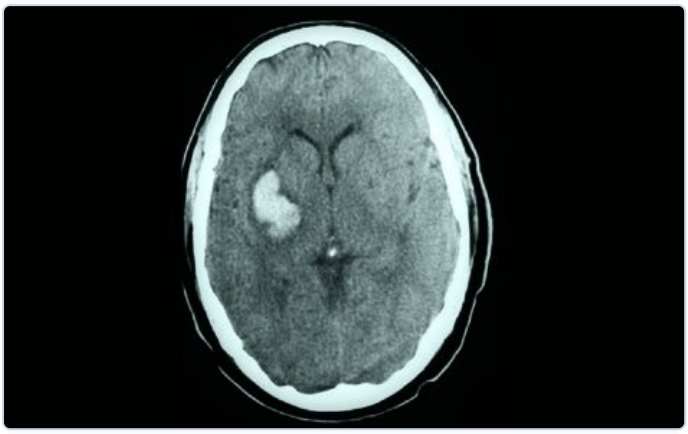
- De reposo, asimétrico

Ficha n.° 29 · p. 18

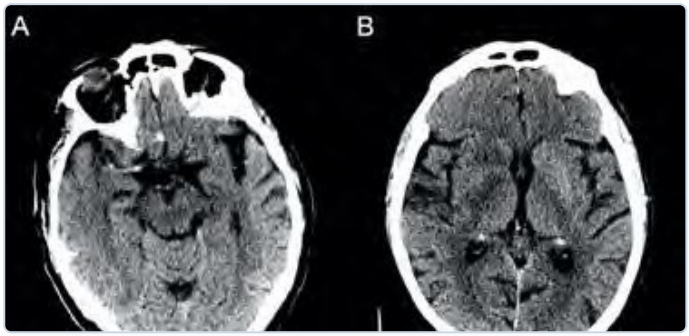
**LA DIFERENCIA** El esencial mejora con alcohol y propranolol.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Hemorragia vs infarto en la TC



VS




### A Hematoma profundo (putaminal)

- Hiperdenso

Ficha n.° 10 · p. 8

### B ACV isquémico: signos precoces en la TC

- Hipodenso o normal

Ficha n.° 01 · p. 4

**LA DIFERENCIA** La TC descarta sangre antes de trombolizar.

# Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

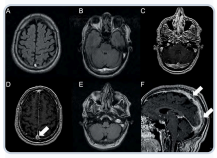


## CRUZ CALIENTE

Cruz hiperintensa en la protuberancia.

**Se ve en:** Atrofia multisistémica.

Tomo p. 73 · Atlas: ficha n.° 30, p. 18



## DELTA VACÍO

Seno trombosado rodeado de contraste.

**Se ve en:** Trombosis del seno sagital.

Tomo p. 32 · Atlas: ficha n.° 19, p. 13



## SIGNO DE FROMENT

Flexión del pulgar al apretar un papel.

**Se ve en:** Neuropatía cubital.

Tomo p. 115 · Atlas: ficha n.° 53, p. 30



## ÉMBOLO DE HOLLENHORST

Placa brillante en una arteriola retiniana.

**Se ve en:** Ateroembolia carotídea.

Tomo p. 14 · Atlas: ficha n.° 05, p. 6

# Índice por tipo de imagen

| 18 | 15 | 28 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| FOTO CLÍNICA | ESQUEMA | IMAGEN RADIOLÓGICA | TRAZADO (ECG / REGISTRO) | FONDO DE OJO |


## Foto clínica · 18

15 Parálisis del III par (10.4) 11
22 Síndrome de Horner en la cefalea en racimos (10.7) 14
25 Stevens-Johnson por anticonvulsivantes (10.8) 16
26 Hiperplasia gingival por fenitoína (10.8) 16
27 Mordedura lateral de la lengua (10.10) 17
35 Crisis oculógira (10.13) 21
42 Ptosis miasténica: antes y después (10.17) 24
43 Ptosis miasténica (10.17) 25
44 Test del hielo (10.17) 25
45 Defecto pupilar aferente relativo (10.18) 26
47 Oftalmoplejía internuclear (10.18) 27
49 Parálisis facial periférica (10.19) 28
51 Síndrome de Ramsay Hunt (10.19) 29
52 Maniobra de Phalen (10.19) 29
53 Signo de Froment (10.19) 30
54 Atrofia de los intrínsecos de la mano (10.19) 30
55 Mano caída (10.19) 31
61 Escara sacra necrótica (10.22) 34

## Esquema · 15

14 Localización de los aneurismas (10.4) 10
21 Aura visual: espectro de fortificación (10.6) 14
23 Ramas del trigémino (10.7) 15
28 Micrografía (10.11) 17
29 Postura parkinsoniana (10.11) 18
33 Espiral con temblor (10.13) 20
34 Espiral de Arquímedes (10.13) 20
38 Test del reloj (10.14) 22
50 Parálisis facial central vs periférica (10.19) 28
57 Maniobra de Dix-Hallpike (10.20) 32
58 Maniobra de Epley (10.20) 32
60 Sitios frecuentes de úlceras por presión (10.22) 33
63 Fractura subcapital del fémur (10.23) 35
64 Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV) (10.23) 35
65 Cascada de prescripción (10.24) 36

## Imagen radiológica · 28

01 ACV isquémico: signos precoces en la TC (10.1) 4
02 Infartos establecidos por territorio (10.1) 4
03 AngioTC: oclusión de la ACM (10.1) 5
04 RM de difusión: infarto (10.2) 5
06 Estenosis carotídea en la angiografía (10.2) 6
07 RM con difusión y perfusión (10.2) 7
08 Angiografía carotídea normal (10.2) 7
10 Hematoma profundo (putaminal) (10.3) 8
11 Hematoma talámico (10.3) 9
12 Hematoma lobar (10.3) 9
13 Hematoma cerebeloso (10.3) 10
17 Hidrocefalia (10.4) 12
19 Trombosis del seno sagital (10.5) 13
20 Defecto de relleno venoso (10.5) 13
30 Signo de la cruz caliente (10.12) 18
31 Leucoaraiosis e infartos lacunares (10.12) 19
32 Leucoaraiosis en RM FLAIR (10.12) 19
36 Atrofia hipocampal (10.14) 21
37 PET-FDG en Alzheimer (10.14) 22
39 Hidrocefalia normotensiva (10.14) 23
40 Hidrocefalia normotensiva en TC y RM (10.14) 23
41 Demencia frontotemporal (10.15) 24
46 Neuritis óptica en la RM (10.18) 26
48 Neuromielitis óptica (10.18) 27
59 Atrofia cerebelosa (10.20) 33
62 Fractura de cadera (10.23) 34
69 Metástasis óseas múltiples (10.26) 38
70 Compresión medular epidural (10.26) 38

## Trazado (ECG / registro) · 5

09 Fibrilación auricular (10.2) 8
24 Crisis de ausencia en el EEG (10.8) 15
56 Registro del impulso cefálico (10.20) 31
67 IAM anterior con SDST (10.25) 37
68 IAM inferior con SDST (10.25) 37

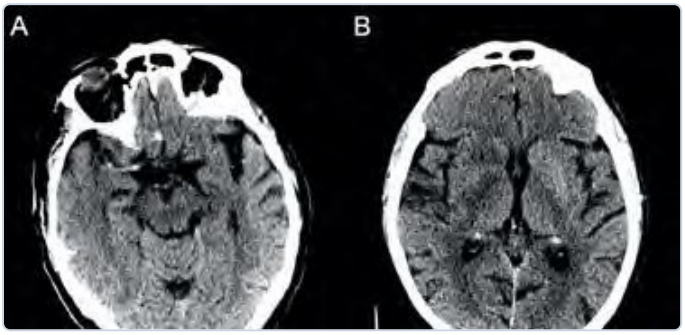
## Fondo de ojo · 4

05 Émbolo de Hollenhorst (10.2) 6
16 Síndrome de Terson (10.4) 11
18 Papiledema (10.5) 12
66 Retinopatía hipertensiva (10.25) 36

# Autoevaluación

7 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

**1** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



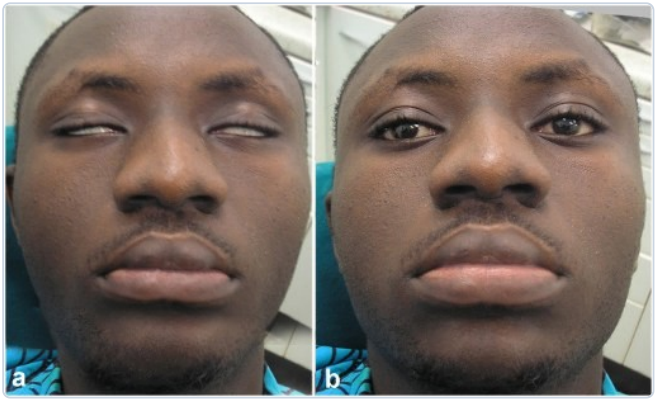

**2** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



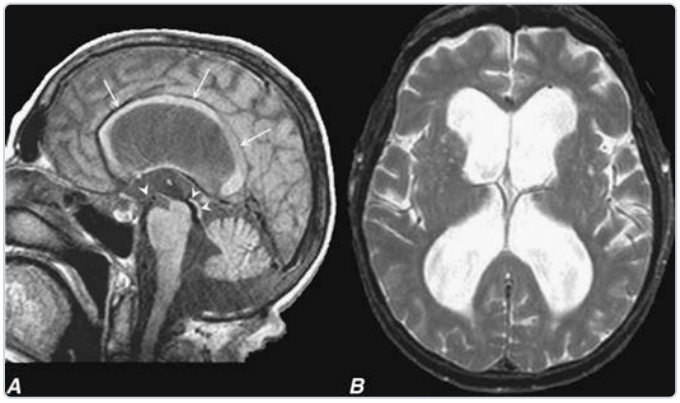
**3** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



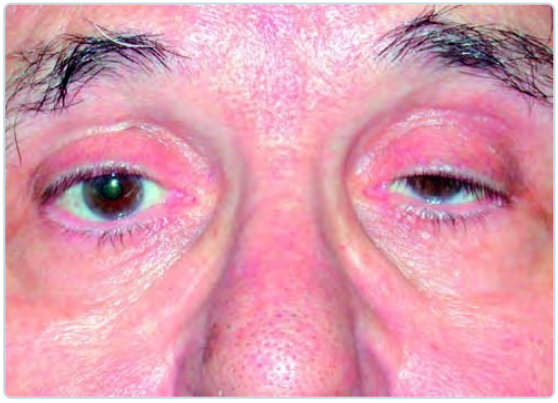
**4** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




**5** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




**6** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**7** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



# Soluciones de la autoevaluación

| N.° | DIAGNÓSTICO | LO QUE LO CONFIRMA | FICHA |
|---|---|---|---|
| 1 | **ACV isquémico: signos precoces en la TC** | ACM hiperdensa | 01 · p. 4 |
| 2 | **Parálisis del III par** | Ojo desviado afuera | 15 · p. 11 |
| 3 | **Mordedura lateral de la lengua** | Mordedura lateral | 27 · p. 17 |
| 4 | **Crisis oculógira** | Ojos desviados arriba | 35 · p. 21 |
| 5 | **Hidrocefalia normotensiva** | Ventrículos dilatados | 39 · p. 23 |
| 6 | **Ptosis miasténica** | Ptosis | 43 · p. 25 |
| 7 | **Parálisis facial periférica** | Ojo que no cierra | 49 · p. 28 |